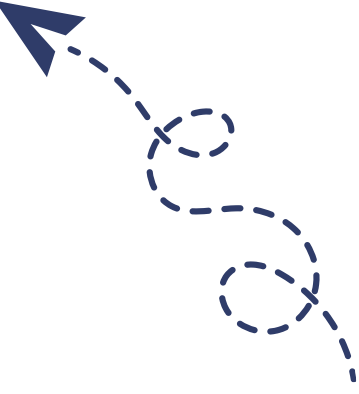




قناة تانية تمريضيانو على التليجرام



الجزء العملي للتمريض الجراحي الطبي

المحتويات :-

1. الفصل الأول

- عينة دم شعرية لاختبار الجلوكوز
- رعاية القسطرة الوريدية

2. الفصل الثاني:

- ضمادة العناية بالجروح

3. الفصل الثالث

- العلاج الطبيعي للصدر
- العناية بأنبوب الصدر

4. الفصل الرابع

- مراقبة القلب ومقياس التأكسج النبضي

• تخطيط القلب
الكهربائي

5. الفصل الخامس

- التغذية بالأنبوب الأنفي المعدي
- العناية بفغر القولون

6. الفصل السادس

- العناية بالقسطرة البولية

7. الفصل السابع

- مقياس غلاسكو للغيوبة

8. الفصل الثامن

- العناية بالصب والجر

عينة دم شعرية لاختبار الجلوكوز

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تحديد عينة الدم الشعرية لاختبار الجلوكوز
- تحديد هدف عينة الدم الشعرية لاختبار الجلوكوز
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء
- عرض عينة الدم الشعرية لإجراء اختبار الجلوكوز

- تسمح مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم للمرضى الذين يعانون من داء السكري بإدارة مرضهم ذاتيًا. يعد الحصول على الدم الشعري عن طريق ثقب الجلد أقل إيلامًا من بزل الوريد، كما أن سهولة طريقة ثقب الجلد تجعل من الممكن للمرضى إجراء هذا الإجراء.

- **الهدف** من هذا الاختبار يستخدم مرضى السكري هذا النوع من الاختبارات كاختبار مهم جزء من إدارة المرض لمراقبة نسبة السكر في الدم وضبط التدخلات في نمط الحياة والعلاج

> معدات

- جهاز قياس نسبة السكر في الدم
- مشرط معقم
- كرات القطن أو مربعات الشاش
- قفازات غير معقمة
- معدات الوقاية الشخصية الإضافية، كما هو موضح
- منظف للبشرة ومسحة ماء أو كحول
- شرائط اختبار العداد

> إجراء

خطوات	عقلاني
1. جمع المعدات. التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية يوفر هذا نهجًا منظمًا على شرائط فحص الدم.	إلى المهمة. شرائط فحص الدم التي هي قد يؤدي تاريخ انتهاء الصلاحية السابق إلى نتائج غير دقيقة ولا ينبغي أن تكون يستخدم.
2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنشار إليه.	نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع انتقال الكائنات الحية الدقيقة. معدات الوقاية الشخصية يكون مطلوب قائم على على احتياطات النقل.
3. التعرف على المريض. اشرح الإجراء تحديد هوية المريض يضمن للمريض وإرشاد المريض بشكل صحيح حول الحاجة إلى مراقبة التدخل الدموي ويساعد على الوقاية الجلوكوز	مريض مستقبل ال أخطاء. التفسير يساعد على التخفيف

القلق وتسهيل التعاون.	
إغلاق الستارة أو الباب يوفر من أجل خصوصية المريض	4. أغلق الستائر حول السرير وأغلقها باب الغرفة إن أمكن.
	5. تحضير المشروط باستخدام تقنية معقمة. تقنية التعقيم تحافظ على العقم
إعادة التغطية الفورية تحمي الشرائط من التعرض للرطوبة والضوء و تغير اللون. مطابقة الأرقام الموجودة على الشريط والجلوكوز تضمن الشاشة أن الجهاز موجود تمت معاييرها بشكل صحيح.	6. قم بإزالة شريط الاختبار من القارورة. خلاصة الحاوية على الفور. تأتي شرائط الاختبار أيضًا مغلفة بشكل فردي. تأكد من أن رقم الكود الخاص بالشريط يتطابق مع رقم الكود الموجود على شاشة الشاشة.
	7. أدخل الشريط في العداد وفقًا للشريط الذي تم إدخاله بشكل صحيح والذي يسمح بالعداد توجيهات لهذا الجهاز المحدد. لقراءة مستوى الجلوكوز في الدم وبدلاً من ذلك، يمكن وضع الشريط في العداد بدقة. بعد جمع العينات على شريط الاختبار، اعتماداً على العداد المستخدم.
	
الغسيل بمنظف البشرة و الماء أو الكحول ينظف موقع الثقب. يساعد الماء الدافئ أيضًا على التسبب في توسع الأوعية الدموية. يمكن أن يتداخل الكحول مع دقة النتائج إذا لم يتم تجفيفه بالكامل	8. تنظيف البشرة بمسحة الكحول. اترك البشرة لتجف تمامًا.
	9. امسك المشروط بشكل عمودي على الجلد وامسك المشروط في الوضع الصحيح ثقب الموقع باستخدام المشروط
يسهل اختراق الجلد بشكل صحيح.	
الشركات المصنعة يوصي التخلص من أول قطرة دم، والتي قد تكون ملوثة بـ	10. امسح أول قطرة دم بالشاش كرة مربعة أو قطنية إذا أوصى بها الشركة المصنعة للشاشة

المنتج، مصل أو التطهير إنتاج قراءة غير دقيقة.	
قطرة بحجم مناسب	11. تشجيع النزيف عن طريق خفض مستوى الأنزيم المحول للأنجيوتنسين اليدين، والاستفادة من الجاذبية. يسهل نتائج الاختبار الدقيقة بشكل خفيف. قم بضرب الإصبع، إذا لزم الأمر، حتى لقد تشكلت كمية كافية من الدم تغطية منطقة العينة على الشريط
قد يؤدي اختبار تلطيخ الدم على الشريط إلى يؤدي إلى نتائج اختبار غير دقيقة	12. المس قطرة دم بلطف على نزعها دون تلطيخها 
	13. قم بالضغط على موقع الوخز بالضغط الذي يسبب وقف النزيف. الكحول كرة قطنية أو شاش جاف. لا تستخدم اللسعات وقد يؤدي إلى إطالة النزيف. مندبل الكحول.
يعتمد على نوع العداد.	14. قراءة نتائج نسبة السكر في الدم والتوقيت قم بتوثيق ذلك بشكل مناسب بجانب السرير. إبلاغ المريض بنتيجة الاختبار.
	15. قم بإيقاف تشغيل العداد، وإزالة شريط الاختبار، والتخلص السليم يمنع التعرض له التخلص من الإمدادات بشكل مناسب. وضع الدم والإبر العرضية. مشروط في حاوية الأدوات الحادة.
إزالة معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح يقلل من خطر انتقال العدوى وتلوث العناصر الأخرى. نظافة اليدين تقلل من انتقال العدوى الكائنات الحية الدقيقة.	16. قم بإزالة القفازات وأي معدات الوقاية الشخصية الأخرى، إذا يستخدم. قم بإجراء نظافة اليدين.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1 المحاكمة 2 المحاكمة 3	تعليق
1. جمع المعدات.			
2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنِشِر إليه			
3. التعرف على المريض. اشرح الإجراء إلى المريض وإرشاد المريض حول الحاجة إلى رصد نسبة الجلوكوز في الدم			
4. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إن أمكن			
5. تحضير المشروط باستخدام تقنية التعقيم			
6. قم بإزالة شريط الاختبار من القارورة. قم بإعادة تغطية الحاوية على الفور. تأكد من أن رقم الكود الخاص بالشريط يتطابق مع رقم الكود على شاشة الشاشة.			
7. أدخل الشريط في العداد وفقاً لتوجيهات لهذا الجهاز المحدد.			
8. تنظيف البشرة بمسحة الكحول. اترك البشرة لتجف تماماً.			
9. امسك المشروط بشكل عمودي على الجلد و ثقب الموقع باستخدام المشروط			
10. امسح أول قطرة دم بالشاش إذا أو مربع قطن كرة موصى به من قبل الشركة المصنعة للشاشة			
11. تشجيع النزيف عن طريق خفض اليد، والاستفادة من الجاذبية. ضربة خفيفة الإصبع، إذا لزم الأمر، حتى يصبح كافياً تشكلت كمية من الدم لتغطية منطقة العينة على الشريط			
12. المس قطرة دم بلطف على شريط اختبار دون تلطيخه			
13. قم بالضغط على موقع الثقب باستخدام كرة قطنية أو شاش جاف. لا تستخدم الكحول مسح.			
14. اقرأ نتائج نسبة السكر في الدم و قم بتوثيقها بشكل مناسب بجانب السرير. إبلاغ المريض بنتيجة الاختبار.			
15. قم بإيقاف تشغيل العداد، وإزالة شريط الاختبار، و التخلص من الإمدادات بشكل مناسب. مكان مشروط في حاوية الأدوات الحادة.			
16. قم بإزالة القفازات وأي معدات الوقاية الشخصية الأخرى، إذا يستخدم. قم بإجراء نظافة اليدين.			

الرعاية الوريدية الطرفية

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تحديد هدف الرعاية الوريدية الطرفية
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء
- إظهار إجراءات الرعاية الوريدية الطرفية

- يعد الموقع الوريدي نقطة دخول محتملة للكائنات الحية الدقيقة إلى مجرى الدم. ولمنع ذلك، يتم استخدام ضمادات وريدية محكمة الغلق لإغلاق الموقع ومنع المضاعفات.
- عندما تكون هناك حاجة لتغيير هذه الضمادات، فمن المهم اتباع تقنية التعقيم الدقيقة لتقليل احتمالية التلوث.

> معدات

- ضمادة انسدادية شفافة
- 2% كلورهيكسيدين، بوفيدون اليود، 70% كحول
- مزيل المادة اللاصقة (اختياري)
- مسحات الكحول
- شريط
- قفازات نظيفة
- منشفة أو وسادة يمكن التخلص منها
- معدات الوقاية الشخصية الإضافية، كما هو موضح

> إجراء

عقلاني	خطوات
متسخ. وجود المعدات المتاحة يحفظ وقت و تنسيق إنجاز الإجراء.	1. تحديد الحاجة لتغيير الملابس. قم بتغيير أي موقع وصول على الفور تحقق من سياسة المنشأة. اجمع كل معدات التضميد الرطبة أو المفككة أو وإحضارها إلى جانب السرير.
إذا كانت نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع ذلك انتشار الكائنات الحية الدقيقة. معدات الوقاية الشخصية هي مطلوب قائم على على انتقال احتياطات	2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، مُشار إليه.
تحديد هوية المريض يضمن الحق يتلقى المريض التدخل و يساعد على منع الأخطاء	3. التعرف على المريض

وهذا يضمن خصوصية المريض. توضيح يخفف قلق و يسهل التعاون. قد توجد حساسية محتملة مرتبطة بالشريط اللاصق أو المطهرات	4. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إن أمكن. اشرح ما ستفعله ولماذا ستفعله أن تفعل ذلك للمريض. اسأل المريض عن الحساسية للشريط ومطهرات الجلد.
من خلع الملابس يمنع	5. ضع قناعًا ثم ضع قناعًا على المريض، إذا كان من الضروري استخدام الأقمشة للقسطرة مع الإشارة إلى ذلك. ارتدي القفازات. ضع منشفة أو وسادة طويلة الأمد أو إذا كان المريض يستخدم وسادة يمكن التخلص منها تحت الذراع مع ضعف المناعة. القفازات تمنع الوصول الوريدي. إذا كان المحلول ملامسًا حاليًا للدم وسوائل الجسم. ضخ الوسادة، إيقاف التسريب مؤقتًا. يحمي السطح الأساسي. مناسب أمسك القسطرة في مكانها باستخدام جهاز التخلص الخاص بك اليد غير المهيمنة وإزالة الكائنات الحية الدقيقة بعناية. الضمادة القديمة و/أو جهاز التثبيت/التأمين. استخدم مزيل المادة اللاصقة حسب الضرورة. تخلص من الضمادة 
الالتهاب (الالتهاب الوريدي)، العدوى، أو إذا يسبب التسلل صدمة للأنسجة و يتطلب إزالة الوريد جهاز الوصول.	6. فحص الموقع الرابع لوجود الالتهاب الوريدي (التهاب)، عدوى، أو تسلل. قم بإيقاف IV ونقله، إذا تمت الإشارة إلى ذلك.
	7. تنظيف الموقع بمحلول مطهر مثل حركة الفك وطول المدة كما أن الكلورهيكسيدين أو وفقًا للمنشأة (30 ثانية على الأقل) ضروري لـ سياسة. تطبيق الكلورهيكسيدين باستخدام الكلورهيكسيدين الخلفي ليكون فعالاً فرك الاحتكاك ذهابًا وإيابًا لمدة 30 دقيقة على الأقل ثواني. لا تمسح أو تلمخ. اتركها لتجف بالكامل.
ارتداء الملابس الشفافة يسمح بسهولة التصوير وحماية الموقع.	8. ضع ضمادة شفافة معقمة موقع بزل الوريد 

يكفي سحبه من الوريد إذا لم يكن مثبتًا بشكل جيد.	9. تزيين الملصق بالتاريخ ووقت التغيير، يساعد وضع العلامات على ضمان التواصل والأحرف الأولى. قم بتدوير الأنابيب بالقرب من المدخل حول ضمادة موقع الوصول الوريدي الموقع، والمرساة مع تغيير الشريط (غير المسبب للحساسية). وزن الأنابيب هو قريب من الموقع 
يعزز راحة المريض وسلامته. إزالة القفازات بشكل صحيح يقلل من خطر انتقال العدوى وتلوث العناصر الأخرى.	10. إزالة المعدات. تأكد من المريض الراحة. إزالة القفازات. السرير السفلي، إن لم يكن في أدنى موضع.
خطر انتقال العدوى و تلوث العناصر الأخرى. يد النظافة تمنع انتقال العدوى الكائنات الحية الدقيقة.	11. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. يؤدي إجراء إزالة معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح إلى تقليل نظافة اليدين.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	محاكمة	3 تعليق
1. تحديد الحاجة لتغيير الملابس. تحقق من سياسة المنشأة. جمع كافة المعدات و أحضره إلى جانب السرير.					
2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنِشِر إليه.					
3. التعرف على المريض					
4. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إذا كان ذلك ممكناً. اشرح ما ستفعله للمريض. اسأل المريض عن الحساسية للشريط ومطهرات الجلد.					
5. ضع قناعاً ثم ضع قناعاً على المريض، إذا مُنِشِر إليه. ارتدي القفازات. ضع منشفة أو وسادة يمكن التخلص منها تحت الذراع مع الوريد وصول. إذا كان المحلول يتم ضخه حالياً، أوقف التسريب مؤقتاً. امسك القسطرة في مكانه بيدك غير المهيمنة و بعناية يزبل قديم خلع الملابس و/أو جهاز التثبيت/التأمين. استخدم مادة لاصقة مزبل حسب الضرورة. تخلص من الضمادة					
6. افحص الموقع الوريدي بحثاً عن وجود التهاب وريدي (التهاب) أو عدوى أو ارتشاح. قم بإيقاف IV ونقله، إذا تمت الإشارة إلى ذلك.					
7. تنظيف الموقع بمحلول مطهر مثل الكلورهيكسيدين أو وفقاً لسياسة المنشأة. تطبيق الكلورهيكسيدين باستخدام ذهاباً وإياباً فرك الاحتكاك لمدة 30 ثانية على الأقل. لا امسح أو امسح. اتركها لتجف تماماً.					
8. ضع ضمادة شفافة معقمة فوقها موقع بزل الوريد					
9. ملصق التزيين مع التاريخ ووقت التغيير و الأحرف الأولى. قم بتدوير الأنابيب بالقرب من موقع الدخول، و مرساة بشريط لاصق (غير مسبب للحساسية) بالقرب من الموقع					
10. إزالة المعدات. ضمان راحة المريض. إزالة القفازات. السرير السفلي، إن لم يكن في الأسفل وضع.					
11. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. أداء اليد صحة.					

تنظيف الجرح ووضع ضمادة جافة ومعقمة

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف تنظيف الجرح
- حدد هدف تنظيف الجرح ووضع ضمادة جافة ومعقمة
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء
- إظهار كيفية تنظيف الجرح وتطبيق عملية التضميد الجاف والمعقم

- **تنظيف الجروح** يتم إجراؤه لإزالة الحطام والملوثات والإفرازات الزائدة. المحلول الملحي العادي المعقم أو المنظف المحضر تجاريًا هو محلول التنظيف المفضل.

- **الهدف** إن العناية بالجروح تهدف إلى تعزيز إصلاح الأنسجة وتجديدها لاستعادة سلامة الجلد. في كثير من الأحيان، تشمل العناية بالجروح تنظيف الجرح واستخدام الضمادة كغطاء وقائي على الجرح.

- لا يوجد تردد قياسي لعدد المرات التي يجب فيها تغيير الضمادات. يعتمد ذلك على كمية التصريف، وتفضيلات الممارس الأساسي، وطبيعة الجرح، ومنتج العناية بالجروح المحدد المستخدم.

➤ معدات

- قفازات معقمة
- قفازات نظيفة يمكن التخلص منها
- معدات الوقاية الشخصية الإضافية، كما هو موضح
- ضمادات الشاش
- وسادات جراحية أو وسادات بطنية
- مجموعة ضمادات معقمة أو مجموعة خياطة (للمقص والملقط المعقم)
- محلول تنظيف معقم حسب الطلب (عادةً محلول ملحي عادي بنسبة 0.9%، أو منظف جروح مُجهز تجاريًا)
- حوض معقم (قد يكون اختياريًا)
- ستارة معقمة (قد تكون اختيارية)
- كيس بلاستيكي أو حاوية نفايات مناسبة أخرى للضمادات المتسخة
- وسادة مقاومة للماء وبطانية حمام
- شريط أو ربطات عنق
- بطانية حمام أو أغطية أخرى لتغطية المريض
- الضمادات والإمدادات الإضافية المطلوبة أو المطلوبة بناءً على طلب مقدم الرعاية الأولية

> إجراء

عقلاني	خطوات
إجراء التحضير يعزز الكفاءة إدارة الوقت وتنظيمه النهج للمهمة.	1. مراجعة الأمر الطبي للعناية بالجروح مراجعة الأمر وخطة الرعاية العناية بالجروح. جمع الإمدادات اللازمة
نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع انتشار المرض من الكائنات الحية الدقيقة. معدات الوقاية الشخصية مطلوبة على أساس بشأن احتياطات الإرسال.	2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُشار إليه
تحديد هوية المريض يضمن الحق يتلقى المريض التدخل ويساعد منع الأخطاء.	3. التعرف على المريض.
المنظمة تسهل أداء المهمة.	4. تجميع المعدات على طاولة فوق السرير في متناول اليد.
يخفف قلق و	أغلق باب الغرفة إذا كان ذلك ممكناً. توضيح اشرح للمريض ما تريد تسهيل التعاون. لفعل
الألم هو تجربة ذاتية متأثرة من خلال الخبرة السابقة. العناية بالجروح و قد يسبب تغيير الضمادات الألم بعض المرضى.	6. تقييم المريض حسب الحاجة المحتملة للتدخلات غير الدوائية لتخفيف الألم أو الأدوية من خلال الخبرة السابقة. العناية بالجروح و المسكنة قبل تغيير ضمادات العناية بالجروح. قد يسبب تغيير الضمادات الألم إدارة الموصوفة المناسبة مسكن. امنح المسكن وقتاً كافياً لتحقيق فعاليته.
	منطقة الجرح.
الفحص يضمن عدم وجود تصريف إزالته عن طريق الخطأ إذا كان موجوداً. ممرضة الضمادات الملوثة ومنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة.	8. التحقق من موضع المصارف أو الأنابيب أو ملحقات أخرى قبل إزالة الضمادة. ارتدِ قفازات نظيفة وقابلة للاستخدام مرة واحدة وفك الشريط اللاصق على الضمادات القديمة



إن إزالة الضمادة بحذر أكثر راحة للمريض
ويضمن عدم إزالة أي تصريف موجود.

9. قم بإزالة الضمادات المتسخة بعناية



محلول ملحي معقم يرطب الضمادة
إزالة أسهل وتقليل الضرر
والألم.

إذا التصق أي جزء من الضمادة
الجلد الأساسي، استخدم كميات صغيرة من
محلول ملحي معقم للمساعدة في تخفيفه وإزالته



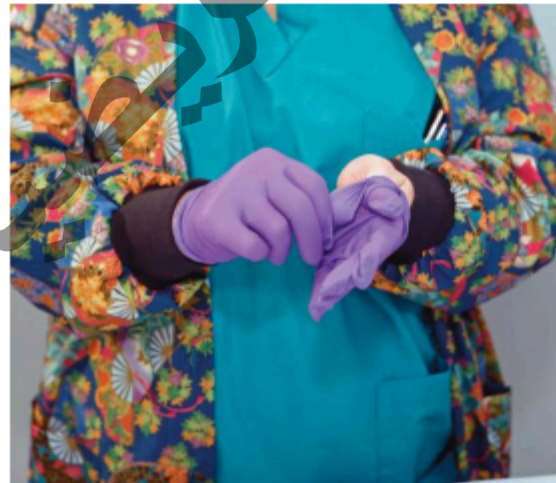
ينبغي توثيق وجود الصرف.

بعد إزالة الضمادة، لاحظ وجود وكمية ونوع ولون ورائحة أي تصريف على الضمادات



التخلص السليم من الضمادات المتسخة والقفايات المستعملة يمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة.

ضع الضمادات المتسخة في وعاء النفايات المناسب. قم بإزالة قفازاتك وتخلص منها في النفايات المناسبة وعاء



أو عدوى ينبغي أن يكون

المظهر والصرف. تقييم ما إذا كان هناك أي تهيج الألم موجود. التحقق من حالة الوثائق. الغرز، شرائط الإغلاق اللاصقة، الدبابيس، والمصارف أو الأنابيب إن وجدت. لاحظ أي مشاكل لتشمل في لك توثيق.

الإمدادات المعقمة في متناول اليد بسهولة و يتم الحفاظ على العقم.

11. باستخدام تقنية معقمة، قم بإعداد منطقة العمل وفتح الإمدادات اللازمة

12. ارتدي قفازات معقمة

إن استخدام القفازات المعقمة يحافظ على التعقيم الجراحي والتقنية المعقمة ويقلل خطر انتشار الكائنات الحية الدقيقة.



13. تنظيف الجرح. تنظيف الجرح

التنظيف من الأعلى إلى الأسفل ومن المنتصف إلى الخارج. يضمن الخارج أن يتم التنظيف من المنطقة الأقل تلوّثًا إلى المنطقة الأكثر تلوّثًا والتي لم تكن ملوثة من قبل. قابل للتنظيف مساحة يكون ملوثة مرة أخرى.

من الأعلى إلى الأسفل ومن المركز إلى الخارج. باتباع هذا النمط، استخدم شاشًا جديدًا لكل مسحة، ثم ضع الشاش المستخدم في وعاء النفايات



باستخدام اسفنجة الشاش بنفس الطريقة. من الكائنات الحية الدقيقة.



الضمادة الأولية تعمل كفتيل لـ تصريف المياه. استخدام الملقط يساعد على ضمان ذلك يتم الحفاظ على التقنية المعقمة.	15. ضعي طبقة من الضمادة الجافة المعقمة فوق الجرح. يمكن استخدام الملقط لتطبيق الضمادة. 
(ABD) فوق الشاش في موقع الجرح ضد الكائنات الحية الدقيقة في الطبقة الخارجية من الضمادة، مثل البيئة وزيادة الامتصاص الصرف الصحي.	ضروري 
التخلص السليم من القفازات يمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة. شريط أو غيره من الأسهل تطبيق منتجات التأمين بعد إزالة القفازات.	17. إزالة القفازات والتخلص منها. ضع الشريط، أشرطة مونتغمري، أو الشاش الدوار لتأمين الضمادات.
و يتظاهر الراحة. إزالة معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح يقلل من المخاطر ل عدوى انتقال و تلوث العناصر الأخرى. يد نظافة يمنع الانتشار الكائنات الحية الدقيقة	التاريخ والوقت. إزالة كافة الاتصالات المتبقية والسرير في أدنى وضع. 19. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. أداء اليد صحة.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	محاكمة 3	تعليق	خطوات الإجراء
					1. مراجعة الأمر الطبي للعناية بالجروح أو خطة الرعاية التمريضية المتعلقة بالعناية بالجروح. جمع الإمدادات اللازمة
					2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنِشِر إليه
					3. التعرف على المريض.
					4. تجميع المعدات على طاولة فوق السرير داخل يصل.
					5. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إن أمكن. اشرح ل صبور ماذا ستفعل
					6. تقييم المريض لاحتمال حاجته إلى أدوية مسكنة للألم. إعطاء المسكنات الموصوفة المناسبة. خصص وقتًا كافيًا ل مسكن للألم لتحقيق فعاليته.
					7. مساعدة المريض على اتخاذ وضع مريح يوفر سهولة الوصول إلى منطقة الجرح.
					8. تحقق من موضع المصارف أو الأنابيب أو الملحقات الأخرى قبل إزالة الضمادة. ارتدي قفازات نظيفة يمكن التخلص منها وقم بفك الشريط اللاصق الموجود عليها الضمادات القديمة
					9. قم بإزالة الضمادات المتسخة بعناية واستخدم كمية صغيرة كميات من المحلول الملحي المعقم للمساعدة في تخفيف وإزالته
					10. بعد إزالة الضمادة، لاحظ وجود وكمية ونوع ولون ورائحة أي تصريف على الضمادات. ضع الضمادات المتسخة في وعاء النفايات المناسب. قم بإزالة قفازاتك وتخلص منها بالطريقة المناسبة وعاء النفايات
					11. فحص موقع الجرح لمعرفة الحجم والمظهر و تصريف المياه. تقييم ما إذا كان هناك أي ألم. تحقق من حالة الغرز، شرائط الإغلاق اللاصقة، الدبابيس، والمصارف أو الأنابيب إن وجدت. لاحظ أي مشاكل لتضمينها في وثائقك.
					12. باستخدام تقنية التعقيم، قم بإعداد عمل معقم المنطقة وفتح الإمدادات اللازمة
					13. ارتدي قفازات معقمة
					14. تنظيف الجرح. تنظيف الجرح من الأعلى إلى من الأسفل ومن المركز إلى الخارج.
					15. بمجرد تنظيف الجرح، جفف المنطقة باستخدام اسفنجة الشاش بنفس الطريقة.

					16. ضعي طبقة من الضمادة الجافة والمعقمة على الجرح. يمكن استخدام الملقط لتطبيق خلع الملابس.
					17. ضع وسادة جراحية أو وسادة بطنية (ABD) فوقها الشاش الموجود في موقع الطبقة الخارجية من ارتداء الملابس حسب الضرورة
					18. إزالة القفازات والتخلص منها. ضع شريطًا لاصقًا أو أحزمة مونتجومي أو شاشًا أسطوانيًا لتأمين ضمادات.
					19. بعد تأمين الضمادة، قم بوضع علامة عليها بالتاريخ والوقت. إزالة جميع المعدات المتبقية؛ ضع المريض في وضع مريح، مع القضبان الجانبية للأعلى والسرير في أدنى موضع.
					20. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. قم بإجراء نظافة اليدين.

إجراء ري الجرح

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف الري الجرحي
- تحديد هدف ري الجروح
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء
- إجراء ري الجرح

- الري هو تدفق موجه للمحلول فوق الأنسجة. يُطلب ري الجروح لتنظيف المنطقة من مسببات الأمراض والحطام الآخر وتعزيز التئام الجروح. قد تكون إجراءات الري أيضًا
- يُطلب تطبيق الحرارة أو المطهرات محليًا، وغالبًا ما يكون المحلول الملحي العادي هو المحلول المفضل عند ري الجروح.

> معدات

- مجموعة ري معقمة، تتضمن حوضًا وحاًوية ري ومحقنة ري
- محلول ري معقم حسب الطلب، يتم تسخينه إلى درجة حرارة الجسم، عادة 0.9% محلول ملحي عادي
- كيس بلاستيكي أو حاوية نفايات أخرى للتخلص من الضمادات المتسخة
- قفازات معقمة
- ستارة معقمة (قد تكون اختيارية)
- قفازات نظيفة يمكن التخلص منها
- ثوب مقاوم للرطوبة وقناع وحماية للعين
- معدات الوقاية الشخصية الإضافية، كما هو موضح
- مجموعة ضمادات معقمة أو مجموعة خياطة (للمقص والملقط المعقم)
- وسادة مقاومة للماء وبطانية حمام، حسب الحاجة
- ضمادات الشاش المعقمة
- شاش تعبئة معقم حسب الحاجة
- شريط أو ربطات عنق
- مناديل واقية للبشرة

> إجراء

خطوات	عقلاني
1. مراجعة الأمر الطبي للعناية بالجروح مراجعة الأمر وخطة الرعاية	إجراء التحضير بعزز الكفاءة إدارة الوقت وتنظيمه النهج للمهمة.
2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنشار إليه.	نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع انتشار المرض من الكائنات الحية الدقيقة. معدات الوقاية الشخصية مطلوبة على أساس بشأن احتياطات الإرسال.
3. التعرف على المريض	تحديد هوية المريض يضمن الحق يتلقى المريض التدخل ويساعد منع الأخطاء.
4. أغلق الستائر حول السرير و أغلق باب الغرفة إذا كان ذلك ممكناً. اشرح ما ستفعله	وهذا يضمن خصوصية المريض. توضيح يخفف قلق و يسهل التعاون.
غير دوائي قبل العناية بالجروح و/أو تضميد بعض المرضى. يتغير. إداري مناسب مسكن موصوف. إتاحة الوقت الكافي لكي يحقق المسكن تأثيره الفعالية قبل البدء إجراء.	تخفيف الألم من خلال الخبرة السابقة. العناية بالجروح و التدخلات أو تغيير ضمادات الأدوية المسكنة قد تسبب الألم
6. ضع وعاء أو كيس النفايات في موقع مناسب للاستخدام أثناء الإجراء.	إن وجود حاوية نفايات في متناول اليد يعني يمكن التخلص من الضمادة المتسخة بسهولة، بدون ال انتشار من الكائنات الحية الدقيقة
سوف يتدفق محلول الري من الأقل نهاية. استخدم بطانية الحمام لتغطية أي حماية للأسطح الأساسية منطقة مكشوفة أخرى غير الجرح. مكان وسادة مقاومة للماء تحت موقع الجرح.	الوضع الذي يوفر سهولة الوصول إلى البطانية يوفر الراحة والدفع. منطقة الجرح. ضع المريض بحيث تقوم الجاذبية بتوجيه تدفق السائل من ملوث إلى الأكثر نهاية نظيفة للجرح باتجاه المنطقة الملوثة الأكثر قذارة. وسادة مقاومة للماء
8. قم بإزالة الضمادات المتسخة بعناية إذا يلتصق أي جزء من الضمادة بالجلد الأساسي، استخدم كميات صغيرة من محلول ملحي معقم للمساعدة في تخفيفه وإزالته	الإزالة الحذرة للضمادة هي أكثر مريح للمريض ويضمن عدم إزالة أي تصريف موجود. محلول ملحي معقم يربط الضمادة إزالة أسهل وتقليل الضرر والألم.

أي تصريف على الضمادات. ضمادات المكان والقفاذات المستعملة تمنع	الضمادات المتسخة في انتشار النفايات المناسبة للكائنات الحية الدقيقة. وعاء.
المعلومات تقدم أدلة حول عملية التئام الجروح و/أو وجود العدوى.	10. قم بتقييم الجرح من حيث المظهر، هذا المرحلة، وجود الخشارة، الأنسجة الحبيبية، النخر، والجهاز الجيني، والصرف. تقييم مظهر الأنسجة المحيطة
الكائنات الحية الدقيقة استخدام المحلول الدافئ يمنع التبريد المريض وقد يقلل من الانزعاج المعقم للمريض. تقنية التعقيم والقفاذات الحفاظ على التعقيم الجراحي.	الوعاء 12. قم بإعداد حقل معقم، إذا لزم الأمر، و مستلزمات تنظيف الجروح. صب محلول الري المعقم الدافئ في حاوية. ارتدي القفاذات المعقمة
سائل ملوث.	جرح لجمع سائل الري
سوف يتجمع المحلول في الحوض و منع الري من الجريان الجلد. يتم حماية أغطية المريض والسريبر من السوائل الملوثة.	14. املا حقنة الري بالمحلول.  باستخدام يدك غير المسيطرة، اضغط بلطف على الحوض على الجلد الموجود أسفل الجرح لتكوين ختم بالجلد 

الجرح. احتفظ بطرف المحقنة من الأقل تلوّنًا إلى الأكثر تلوّنًا
منطقة. ضغط مرتفع
قد يسبب تدفق الري إزعاجًا للمريض بالإضافة
إلى تلف التحبيب
نسيج

على الأقل 1 بوصة فوق الطرف العلوي للملوث
جرح.



الرطوبة توفر وسيلة للنمو
من الكائنات الحية الدقيقة. الرطوبة الزائدة
يمكن المساهمة في الجلد تهيج
انهيار.

16. جفف الجلد المحيط بالشاش
ضمادات



يمتص
انهيار. خلع الملابس
تصريف وحماية الجرح وتعزيزه
شفاء.

الجلد المحيط. ضعي ضمادة جديدة على و
الجرح



التخلص السليم من القفازات يمنع
انتشار الكائنات الحية الدقيقة. شريط أو غيره
تأمين المنتجات أسهل في التطبيق بعد ذلك
تمت إزالة القفازات.

18. إزالة القفازات والتخلص منها. ضع الشريط،
أحزمة مونتغمري، أو الشاش الدوار تأمين
الضمادات.

و يتظاهر	التاريخ والوقت. إزالة كافة الاتصالات المتبقية
الراحة.	والسرير في أدنى وضع.
ل عدوى انتقال و	20. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. أداء اليد إزالة معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح يقلل من المخاطر صحة.
تلوث العناصر الأخرى. يد	
الكائنات الحية	
الدقيقة الصحية	
ال انتشار من	

من قناة تمريض بيانو على التليجرام

> قائمة التحقق من الإجراءات

علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	محاكمة 3	تعليق	خطوات الإجراءات
					1. مراجعة الأمر الطبي للعناية بالجروح أو خطة الرعاية التمريضية المتعلقة بالعناية بالجروح. جمع الإمدادات اللازمة
					2. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنِشِر إليه.
					3. التعرف على المريض
					4. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إذا كان ذلك ممكناً. اشرح ما تريد سوف تفعل
					5. تقييم المريض للحاجة المحتملة لذلك دواء مسكن. إدارة مناسبة مسكن موصوف. خصص وقتاً كافياً لـ مسكن للألم لتحقيق فعاليته.
					6. ضع وعاء النفايات أو الكيس في مكان مناسب مكان للاستخدام أثناء الإجراء.
					7. مساعدة المريض على اتخاذ وضع مريح يوفر سهولة الوصول إلى منطقة الجرح.
					8. قم بإزالة الضمادات المتسخة بعناية واستخدم كميات صغيرة من المحلول الملحي المعقم للمساعدة في تخفيفها. إزالته
					9. بعد إزالة الضمادة، لاحظ وجودها، كمية ونوع ولون ورائحة أي تصريف الضمادات. ضع الضمادات المتسخة في وعاء النفايات المناسب.
					10. قم بتقييم الجرح من حيث المظهر والمرحلة ووجود الخشارة والأنسجة الحبيبية والنخر والجهاز الجبي والتصريف. تقييم المظهر من الأنسجة المحيطة
					11. قم بإزالة قفازاتك ووضعها في وعاء
					12. قم بإعداد حقل معقم، إذا لزم الأمر، ولوازم تنظيف الجروح. صب محلول الري المعقم الدافئ في الحاوية المعقمة. ضع على قفازات معقمة
					13. ضع الحوض المعقم أسفل الجرح جمع سائل الري
					14. املاً حقنة الري بالمحلول. استخدام يدك غير المسيطرة، اضغط عليها بلطف الحوض على الجلد أسفل الجرح تشكيل ختم مع الجلد
					15. قم بتوجيه تيار من المحلول بلطف إلى جرح. احرص على إبقاء طرف المحقنة على مسافة 1 بوصة على الأقل فوق الطرف العلوي للجرح.

					16. جفف الجلد المحيط بضمادات الشاش
					17. ضعي واقياً للجلد على الجلد المحيط. ضعي ضمادة جديدة على الجرح
					18. إزالة القفازات والتخلص منها. ضع شريطاً لاصقاً أو أحزمة مونتجومري أو شاشاً أسطوانياً لتأمين ضمادات.
					19. بعد تأمين الضمادة، ضع عليها ملصقاً بالتاريخ و وقت. قم بإزالة جميع المعدات المتبقية؛ ضع المريض في وضع مريح، مع قضبان جانبية أعلى والسرير في أدنى وضع.
					20. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. قم بإجراء نظافة اليدين.

العلاج الطبيعي للصدر (CPT)

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف العلاج الطبيعي للصدر (CPT).
- تحديد هدف العلاج الطبيعي للصدر (CPT).
- تحديد أوضاع العلاج الطبيعي للصدر (CPT).
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تطبيق العلاج الطبيعي للصدر (CPT).

إعداد العميل لمعدات CPT

- سرير المستشفى أو أي سطح آخر لوضع العميل في وضع الرأس لأسفل
- ثوب أو منشفة (اختياري)
- الأنسجة
- حاوية للبلغم
- قفازات نظيفة
- سماعة الطبيب
- مقياس التأكسج النبضي (إذا لزم الأمر)
- غسول الفم/منتج نظافة الفم

إجراء	
عقلاني	فعل
هذه الإجراءات مرهقة للعملاء، وتستغرق وقتًا طويلاً، ويمنع استخدامها حالات من هشاشة العظام، رئوي الانسداد، أو أمراض القلب، أو سرطان الرئة، أو غيرها من الحالات غير المرتبطة بالإفراط في إنتاج البلغم. عادة، المناطق السفلية هي الأكثر متأثر	1. التحقق من صحة أمر الطبيب لـ CPT. 2. قم بإجراء نظافة اليدين. 3. إعطاء CPT قبل أو بعد ساعتين على الأقل من تناول الطعام لمنع القيء 4. تحديد موقع أجزاء الرئة إذا كان من المقرر أن يخضع مجال الرئة بأكمله لـ CPT؛ فيجب تصريف الجزء المصاب أولاً. 5. توفير الخصوصية . 6. قم بإعداد العميل من خلال شرح CPT والغرض منه. 7. استمع إلى الصدر بحثًا عن أصوات التنفس و مغامر الأصوات قبل العلاج.

8. احصل على قياس التأكسج النبضي (SPO2) إذا لزم الأمر قبل العلاج	
9. ضع منشفة على الجلد عند إجراء CPT (اختياري).	

إجراء تصريف الوضعية

إجراء	فعل
عقلاني	1. قم بفك أي ملابس ضيقة. 2. قم بخفض رأس السرير ببطء بحيث يتم وضع رأس العميل بزاوية لا تزيد عن 25° لأسفل. 3. ضع حاوية البلغم والأنسجة في متناول العميل. 4. أخبر العميل بالبقاء في مكانه لمدة 3-15 دقيقة. 5. اطلب من العميل أن يطرد الإفرازات. 6. اطلب من العميل أن يتجه إلى الجانب الآخر، ثم إلى وضعية الاستلقاء، ثم كرر الإجراء. ملحوظة: يجب على العملاء التنفس بعمق بين تغييرات الوضع. 7. مساعدة العميل على العودة ببطء إلى وضعية الجلوس الطبيعية بعد السعال في أوضاع التبعية. 8. تحديد قياس التأكسج النبضي إذا تم طلبه. 9. استمع إلى مناطق الصدر لتحسين أصوات التنفس. 10. لاحظ الحرف وقم بقياس البلغم، ثم تخلص منه. 11. قم بإزالة القفازات وقم بنظافة اليدين. 12. توفير نظافة الفم بعد الإفراز نخامة.
عقلاني	تساعد الجاذبية على تحريك الإفرازات يمكن إضافة الإيقاع والاهتزاز إلى المساعدة في تعبئة الإفرازات (المهارات اللازمة يتبع).

أداء قرع الصدر

فعل	عقلاني
1. قم بتغطية المنطقة المراد قرعها بالثوب أو منشفة القماش (اختياري). 2. إمساك الذراعين مع ثني المرفقين قليلاً، ضع يديك بالإبهام والأصابع مغلق. الحفاظ على المعصمين مرتخين ومسترخيين، ثني المعصمين وتمديدتهما بشكل إيقاعي للتصفيق فوق المنطقة المراد تصريفها.	هذه الحركة تنتج اهتزازات قم بتخفيف الإفرازات لتسهيل إزالتها السعال أو الشفط.

لا تنتقل الاهتزازات إلى الصدر الجدار من خلال العظام أو أنسجة الثدي والقرع في هذه المناطق يمكن أن يسبب عدم الراحة.  أداء الإيقاع والاهتزاز مع كل تغيير في الموقف.	3. قرع بالتناوب بين اليدين والاستماع إلى الصوت المجوف مع الضربات. 4. قم بقرع كل منطقة ببطء وإيقاع لمدة 3-5 دقائق. 5. لا تقم بالقرع على النتوءات العظمية، أو الثديين، أو المناطق الحساسة. 6. تشجيع العميل على “النفخ” والسعال بعد قرع مناطق الرئة. 7. قم بفحص جميع مناطق الرئة بحثًا عن أي تغييرات في أصوات التنفس. 8. ارتدِ القفازات، ولاحظ طبيعة البلغم وقم بقياس كميته، ثم تخلص منه. 9. قم بإزالة القفازات وقم بتنظافة اليدين. 10. توفير نظافة الفم. 11. إجراءات الوثيقة وإجراءات العميل استجابة.
--	--

إجراء اهتزاز الصدر

عقلاني	فعل
 ضع يديك بشكل مسطح على المنطقة المراد اهتزازها، مع الحفاظ على صلابة المعصمين. ويؤدي هذا إلى زيادة اضطراب وسرعة الهواء الزفير وتخفيف وتحريك الإفرازات من مجاري الهواء الطرفية.	1. قم بإجراء الاهتزاز بعد التصريف الوضعي والقرع في كل موضع. 2. قم بتغطية المنطقة المراد اهتزازها بالثوب أو المنشفة (اختياري). 3. اطلب من العميل أن يتنفس من خلال الأنف ويزفر ببطء من خلال الشفاه المزمومة. 4. ضع يديك بشكل مسطح فوق المنطقة المراد اهتزازها أو ضع إحدى يديك فوق الأخرى. حافظ على ذراعيك وكتفيك مستقيمتين ومعصميك متصلين. 5. اطلب من العميل أن يستنشق بعمق. 6. عندما يزفر العميل من خلال شفثيه المطبقتين، استخدم ضغطًا معتدلًا لاهتزاز الصدر عن طريق تقلص ذراعيك وكتفيك واسترخائهما بسرعة. 7. اهتز لمدة ثلاثة أو أربعة زفير فوق المنطقة. 8. شجع العملاء على “النفخ” والسعال قبل تغيير المواقف. 9. تقييم العلامات الحيوية، وقياس التأكسج النبضي، والاستماع إلى التنفس أصوات. 10. قفازات دون.

من	11. قابلية القياس و ملحوظة شخصية الإفرازات المقشورة، ثم تخلص منها. 12. قم بإزالة القفازات و قم بنظافة اليدين. 13. توفير نظافة الفم. 14. إجراءات التوثيق واستجابة العميل.
----	---

استخدام نظام تنظيف مجرى الهواء (اللف)

معدات

راجع إعداد العميل لـ CPT

لفافات صدر قابلة للنفخ يمكن التخلص منها ذات حجم مناسب (صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جدًا)

مولد نبضات الهواء مع أنابيب التوصيل

التحضير

1. التحقق من صحة طلب الطبيب للعلاج بتذبذب جدار الصدر عالي التردد وتكرار ومدة العلاج.

2. إجراء نظافة اليدين .

3. تحديد العميل حسب الاسم وتاريخ الميلاد.

4. توفير الخصوصية .

5. اشرح وظيفة وهدف السترة/اللفافة.

6. تقييم أصوات الرئة قبل العلاج.

فعل	عقلاني
1. ارفع رأس السرير أو اطلب من العميل الجلوس على الكرسي. بالتناوب، ضع الغلاف على السرير ولف العميل على الغلاف.	
2. ضعي اللفافة على طبقة واحدة من الملابس، ولفي السترة المنكماشة حول صدر العميل، أسفل الإبطين مباشرة؛ اطلب من العميل أن يستنشق بعمق؛ و قم بتأمينه باستخدام مثبتات الفيلكرو. 3. اضبط المولد على ارتفاع عمل مريح.	يجب أن يتناسب الغلاف بشكل مريح، ولكن لا يكون غير مريح.
4. قفل عجلات المولد. الأساس المنطقي: لمنع الحركة.	
5. قم بإدخال خرطوم الهواء في منفذ الموصل الموجود أمام المولد باستخدام حركة الالتواء والدفع.	
6. قم بتحريك الطرف الآخر من الخرطوم إلى مكان يمكن التخلص منه فتحات السترة .	
7. قم بربط حلقات الفيلكرو لتثبيت خراطيم الهواء في مكانها.	
8. قم بتوصيل سلك الطاقة بالطاقة مدخل على الجزء الخلفي من مولد نبضات الهواء.	
9. قم بتوصيل سلك الطاقة بمنفذ أرضي.	



سترة العميل/لفافة جدار الصدر عالية التردد
العلاج بالتذبذب يزيد من القدرة على التعبئة
 وإزالة إفرازات مجرى الهواء.

يوفر نبض الهواء اهتزازًا لصدر العميل.
سيستمر العلاج لمدة 10 دقائق، ولكن يجب
استئنافه بعد ذلك إذا لزم الأمر. العلاجات
المعتادة هي 10-20 دقائق.

10. اضبط الأسهم لأعلى أو لأسفل لضبط التردد والضغط ووقت العلاج، مع التأكد من أن الإعداد الذي يظهر على الشاشة يطابق الإعدادات الموصوفة.
11. اضغط على زر "ON" للتضخيم سترة يمكن التخلص منها.
12. اضغط على زر "OFF" لإنهاء العلاج قبل الوقت المحدد وسوف ينكمش الغلاف.
13. "اكتملت الجلسة" ستظهر الرسالة على الشاشة عندما اكتمل وقت ضبط العلاج وسوف ينكمش الغلاف.
14. افصل النظام وقم بإزالة خراطيم الهواء والسترة التي تستخدم لمرة واحدة من العميل.
15. قم بتخزين السترة وخراطيم الهواء في المنطقة ثم قم بإرجاعها مولد للتخزين للاستخدام المستقبلي.
16. إعادة تقييم أصوات أنفاس العميل؛ ملاحظة شخصية و مبلغ من السعال/شفط الإفرازات.
17. مساعدة العميل على الوصول إلى وضع مريح.
18. قم بإجراء نظافة اليدين.

أنبوب الصدر

الحفاظ على نظام تصريف جاذبية الصدر/زجاجة الشفط

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف أنبوب الصدر
- تحديد هدف أنبوب الصدر
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تطبيق العناية بأنبوب الصدر.

معدات

- نظام تصريف الصدر بثلاث زجاجات في حامل مع
- تعليمات الشركة المصنعة لاستخدام الشريط
- مصدر الشفط، إذا كان محددًا (على سبيل المثال، شفط الحائط أو مضخة إيمرسون)
- قفازات نظيفة ومعدات حماية شخصية

إجراء	
عقلاني	فعل
تحتوي سداة الزجاجاة على فتحتين، واحدة للدخول من العميل، والأخرى للخروج إلى الغلاف الجوي. تسمح فتحة التهوية للهواء من الحيز الجنبى للعميل بالهروب والحفاظ على الضغط السلبي بالنسبة للضغط داخل الجنبه لدى العميل. الحلقات التابعة سوف تمنع الهواء إزالة.	1. ارتداء القفازات ومعدات الحماية الشخصية. 2. املا زجاجة ختم الماء بـ 300 مل من الماء لغمر أنبوب ختم الماء. 3. قم بتوصيل أنبوب تصريف أنبوب الصدر الخاص بالعميل بأنبوب مانع تسرب الماء لمنع الهواء الجوي من دخول الحيز الجنبى الخاص بالعميل. 4. تأكد من أن فتحة تهوية زجاجة ختم الماء مفتوحة للغلاف الجوي. 5. قم بلف أنبوب التصريف من أنبوب صدر العميل إلى زجاجة مانعة لتسرب المياه بحيث لا تكون هناك حلقات تابعة. 6. تأكد من إغلاق جميع وصلات الأنابيب والزجاجات لضمان إحكام إغلاق النظام. 7. تأكد من سالكية النظام عن طريق ملاحظة "المد والجزر" في الأنبوب تحت الماء. يجب أن يكون السائل يرتفع عند الاستنشاق وينزل عند الزفير. 8. لاحظ فقاعات الهواء العرضية من أنبوب ختم الماء.

9. فحص الأنابيب بحثًا عن أي انسداد.

هذه علامة على أن الهواء يتم إخلاؤه من الحيز الجنبى للعميل
يتوقف المد والجزر عندما تعود الرئة إلى حالتها الطبيعية.
تم توسيع أو انسداد نظام الأنبوب.
وهذا يدل على وجود تسرب للهواء.

10. الإبلاغ عن حالة حدوث فقاعات مستمرة في زجاجة ختم الماء.

11. قم بتقييم عودة أصوات التنفس أو احصل على أشعة سينية على الصدر لتحديد إعادة التوسع.

من قناة تهوية المريض على التليجرام

تطبيق جهاز مراقبة القلب

الأهداف:

سیکون الطلاب قادرین علی:

- تعريف مراقبة القلب.
- تحديد هدف مراقبة القلب.
- تحديد مواضع قطب مراقبة القلب.
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تطبيق جهاز مراقبة القلب.

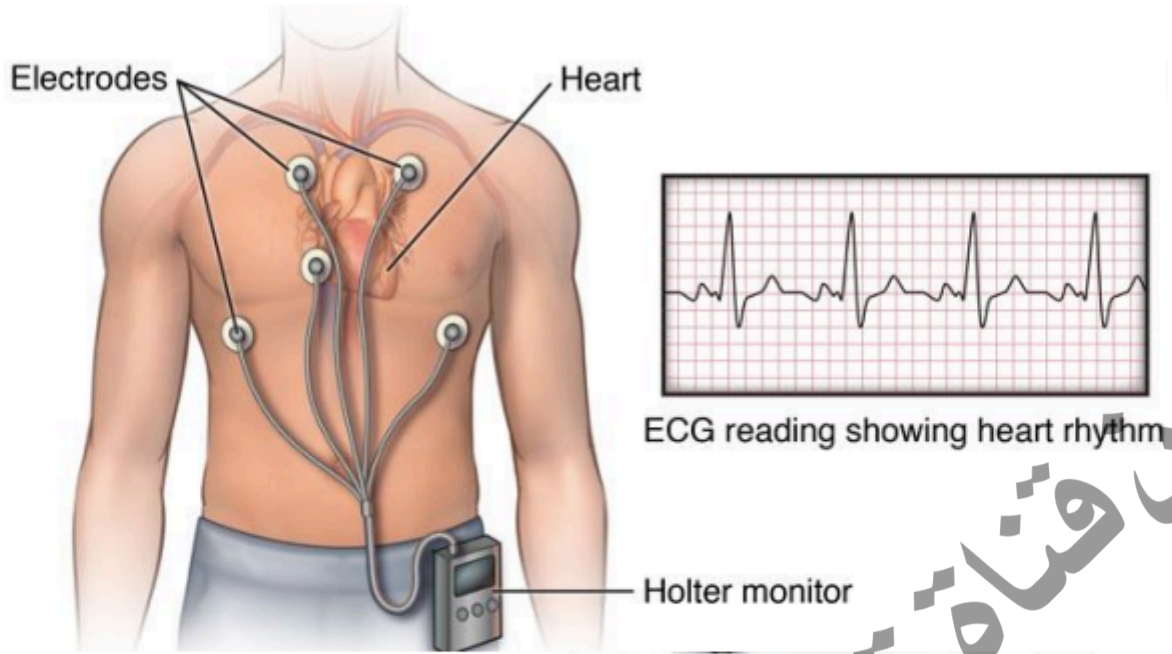
➤ تعريف مراقبة القلب

- جهاز مراقبة القلب بجانب السرير هو جهاز "جهاز مراقبة سلكي أو لاسلكي" يستخدم لتوفير مراقبة مستمرة للنشاط الكهربائي للقلب. (لارسون وبرادي، 2008).

➤ هدف مراقبة القلب

- يتم استخدام مراقبة القلب للمرضى الذين يعانون من اضطرابات التوصيل ولأولئك المعرضين لخطر عدم انتظام ضربات القلب الذي يهدد الحياة، مثل المرضى بعد العملية الجراحية والمرضى الذين يتم تخديرهم.
- يتم الحصول على مراقبة القلب باستخدام ثلاثة أو خمسة أقطاب كهربائية وأسلاك على صدر المريض.
- يستخدم القياس عن بعد جهاز إرسال صغير متصل بمريض متنقل لإرسال إشارات كهربائية إلى موقع آخر، حيث يتم عرضها على شاشة المراقبة. يعد القياس عن بعد مفيداً بشكل خاص لمراقبة عدم انتظام ضربات القلب الذي يحدث أثناء النوم أو الراحة أو ممارسة الرياضة أو المواقف العصيبة.





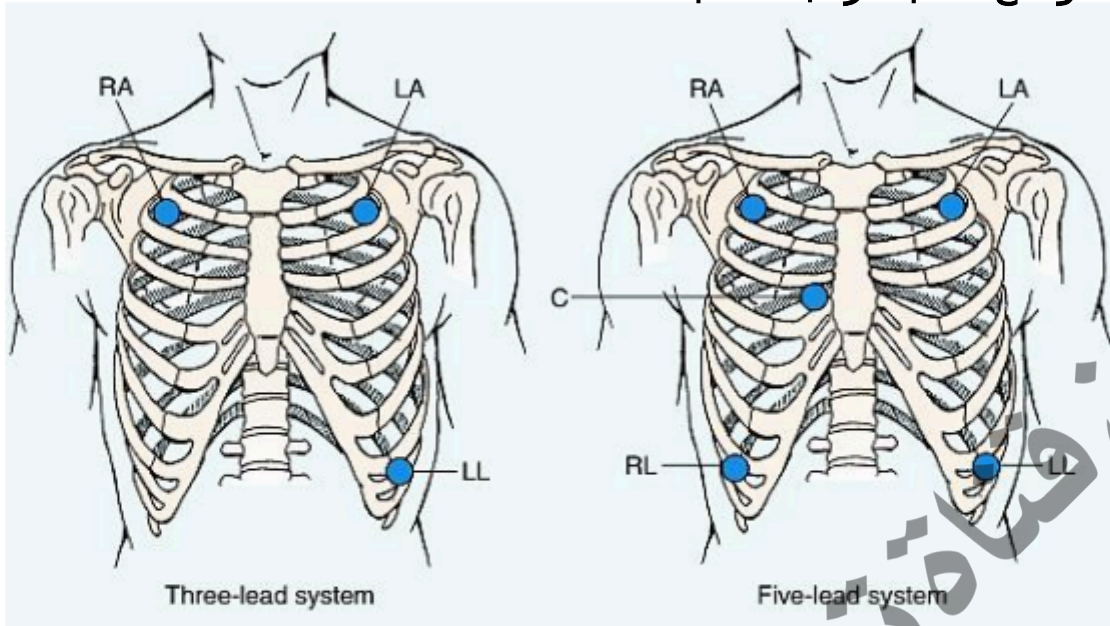
➤ متى تستخدم

- 1- مريض في وحدة العناية المركزة ووحدة العناية القلبية. 2- أثناء العملية وفترة ما بعد الجراحة. 3- مريض يعاني من عدم انتظام ضربات القلب. ➤ **معدات**

1- أسلاك الرصاص. 2- جهاز مراقبة القلب بجانب السرير أو جهاز إرسال القياس عن بعد. 3- أقطاب كهربائية مسبقة الجل (رغوة هلامية) (يتراوح عددها من 3 إلى 5). 4- كابل للمريض لمراقبة القلب بالأسلاك الصلبة. 5- جهاز الإرسال وحقبة جهاز الإرسال وحزمة بطارية القياس عن بعد للقياس عن بعد 6- منظم للبشرة. 7- منشفة نظيفة وجافة، أو منشفة غسيل، أو شاش. 8- مقصات الشعر (اختيارية حسب الشعر في مواقع الأقطاب الكهربائية). 9- معدات الوقاية الشخصية، كما هو مبين.



> مواضع قطب مراقبة القلب



✓ المناصب في نظام القيادة الثلاثية:

1- RA (القطب الأبيض) أسفل الترقوة اليمنى، ICS الثاني، خط منتصف الترقوة الأيمن. 2- LA (القطب الأسود) أسفل الترقوة اليسرى، ICS الثاني، خط منتصف الترقوة الأيسر. 3- LL (القطب الأحمر) القفص الصدري السفلي الأيسر، ICS الثامن، خط منتصف الترقوة الأيسر.

✓ المناصب لنظام الخمسة قادة:

1- RA (القطب الأبيض) أسفل الترقوة اليمنى، ICS الثاني، خط منتصف الترقوة الأيمن. 2- RL (القطب الأخضر) القفص الصدري السفلي الأيمن، ثمانية ICS، خط منتصف الترقوة الأيمن. 3- LA (القطب الأسود) أسفل الترقوة اليسرى، ICS الثاني، خط منتصف الترقوة الأيسر. 4- LL (القطب الأحمر) القفص الصدري السفلي الأيسر، ثمانية ICS، خط منتصف الترقوة الأيسر. 5- الصدر (القطب البني) أي موضع سلك V، عادةً V1 (ICS الرابع، الحد القصي الأيمن).

> إجراء

عقلاني	خطوات
تحديد هوية المريض يضمن الحق يتلقى المريض التدخل و يساعد على منع الأخطاء. يوفر نهجا منظما للمهمة.	1. التحقق من ترتيب مراقبة القلب على هذا يضمن التدخل الصحيح السجل الطبي للمريض. تحديد ما يتم إجراؤه على المريض الصحيح. مريض.
انتشار الكائنات الحية الدقيقة.	2. جمع المعدات.
للحفاظ على الخصوصية وتقليل عدد المرضى مخاوف	3. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا كانت نظافة اليدين ومعدات الوقاية الشخصية تمنع ذلك. مُشار إليه.
	4. أغلق الستائر حول السرير وأغلقها باب الغرفة إن أمكن. يشرح الإجراء للمريض.

	5. افحص الجلد بحثًا عن الزيوت الزائدة أو الرطوبة. إذا كان يوفر تسجيلًا واضحًا ودقيقًا حاصر، امسح الصدر أو الأطراف بشكل نظيف، بدون أي أثر. منشفة جافة. تنظيف وتجهيز منطقة الصدر لوضع الأقطاب الكهربائية بالصابون و ماء.
يسهل وضع القلب بشكل صحيح يقود ويحافظ على تواضع المريض	6. تحضير المريض للإجراء: ✓ إزالة أو تغيير موضع ثوب المريض لكشف صدر المريض فقط. احرص على تغطية البطن والفخذين. ✓ ضع المريض في وضعية الاستلقاء.
لتفسير دقيق لاضطراب النظم.	7. من المهم وضع الأقطاب الكهربائية في المواضع الصحيحة لوضع الأسلاك بشكل صحيح إما نظام ثلاثي أو خمسة أقطاب كهربائية. 
8. قم بتوصيل أسلاك الشاشة بالأقطاب الكهربائية. الألوان يسمح نظام التلوين بالاتساق تطبيق الخيوط.	تمثل الأسلاك قطبيتها.
ضبط المنبه يسمح بالصوت المسموع إشعار إذا كان معدل ضربات القلب خارج الحدود.	9. تحقق من جهاز مراقبة السرير أو القياس عن بعد، فقد يكتشف نظام المراقبة نفسه وجود خلل مشاكل القطب الكهربائي أو الرصاص. استكشف الأخطاء وإصلاحها كاتصال. ضروري.
ضبط المنبه يسمح بالصوت المسموع إشعار إذا كان معدل ضربات القلب خارج الحدود.	10. تعيين الحدود العليا والسفلى ل- إنذار معدل ضربات القلب، بناءً على حالة المريض سياسة الحالة أو الوحدة.
ضبط المنبه يسمح بالصوت المسموع إشعار إذا كان معدل ضربات القلب خارج الحدود.	11. إرجاع المريض إلى مكان مريح للحفاظ على راحة المريض. وضع. خفض ارتفاع السرير وضبطه وضع رأس السرير في وضع مريح.
من انتقال يمنع كائن حي دقيق.	12. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. أداء نظافة اليدين.

➤ اعتبارات التمريض

1- لا يتم تفويض تطبيق جهاز مراقبة القلب إلى طاقم التمريض المساعد. 2- قم بمراجعة السجل الطبي للمريض وخطة الرعاية للحصول على معلومات حول حاجة المريض لمراقبة القلب.

3- تقييم الحالة القلبية للمريض، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، سماع أصوات القلب.

- 4- افحص صدر المريض بحثًا عن مناطق التهيج أو الانهيار أو الشعر الزائد الذي قد يتداخل مع وضع الأقطاب الكهربائية "يجب أن تكون مواقع الأقطاب الكهربائية جافة، مع الحد الأدنى من الشعر".
- 5- قد يكون المريض جالسًا أو مستلقيًا على سرير أو كرسي.
- 6- قم بمراجعة اتجاهات الإنذار وأشكال الموجات مرة واحدة على الأقل في كل نوبة عمل وعند الإبلاغ عن الإنذار. 7- قم بتسجيل شريط إيقاعي واحد على الأقل لكل نوبة عمل لكل سياسة وكالة، إما على الورق أو احفظه في السجل الصحي الإلكتروني (EHR).
- 8- قم بالإبلاغ عن أي نتائج غير متوقعة على الفور إلى مقدم الرعاية الصحية.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	محاكمة 3	تعليق
1. التحقق من ترتيب مراقبة القلب على السجل الطبي للمريض. التعرف على المريض.					
2. جمع المعدات.					
3. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُشار إليه.					
4. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إذا كان ذلك ممكنًا. اشرح الإجراء للمريض.					
5. افحص الجلد بحثًا عن الزيوت الزائدة أو الرطوبة. إذا حاضر، امسح الصدر أو الأطراف بنظافة وجفاف منشفة. تنظيف وتجهيز منطقة الصدر لوضع الأقطاب الكهربائية بالماء والصابون.					
6. تحضير المريض للإجراء: ✓ قم بإزالة ثوب المريض أو إعادة وضعه لكشف صدر المريض فقط. احرص على تغطية البطن والفخذين.					
✓ ضع المريض في وضعية الاستلقاء.					
7. ضع الأقطاب الكهربائية في المواضع الصحيحة لـ إما نظام ثلاثي أو خمسة أقطاب كهربائية.					
8. قم بتوصيل أسلاك الشاشة بالأقطاب الكهربائية. تمثل ألوان الأسلاك قطبيتها.					
9. تحقق من جهاز مراقبة السرير أو محطة القياس عن بعد لأية رسائل تشير إلى القطب الكهربائي أو الرصاص مشاكل. استكشف الأخطاء وإصلاحها حسب الحاجة.					
10. ضبط الحدود العليا والسفلى لإنذار معدل ضربات القلب، بناءً على حالة المريض أو سياسة الوحدة.					
11. إرجاع المريض إلى وضع مريح. خفض ارتفاع السرير وضبط الرأس السرير إلى وضع مريح.					
12. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. أداء نظافة اليدين.					

استخدام مقياس التأكسج النبضي

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف مقياس التأكسج النبضي.
- حدد هدف استخدام مقياس التأكسج النبضي.
- قم بإحصاء الحالات التي قد تؤدي إلى قراءات خاطئة لمقياس التأكسج النبضي.
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- باستخدام مقياس التأكسج النبضي.

> تعريف

- قياس التأكسج النبضي هو قياس غير جراحي لتشبع الأكسجين في الدم الشرياني، وهي النسبة المئوية التي يمتلئ بها الهيموجلوبين بالأكسجين. مقياس التأكسج النبضي هو مسبار مزود بصمام ثنائي باعث للضوء (LED) متصل بواسطة كابل بمقياس التأكسج.

> الهدف من استخدام مقياس التأكسج النبضي

- يعد قياس التأكسج النبضي مفيدًا لمراقبة المرضى الذين يتلقون العلاج بالأكسجين، ومراقبة المعرضين لخطر نقص الأكسجة، ومراقبة المعرضين لخطر نقص التهوية (استخدام المواد الأفيونية، والتسوية العصبية)، والمرضى بعد العملية الجراحية.
- يشير عدم التشبع (انخفاض مستوى SpO2) إلى وجود خلل في تبادل الغازات.
- علامة متأخرة على ضعف الجهاز التنفسي لدى المرضى الذين يعانون من انخفاض معدل وعمق التنفس.
- لا يحل قياس التأكسج النبضي محل تحليل غازات الدم الشرياني. تتوفر أجهزة استشعار للاستخدام على الإصبع، وأصابع القدم، والقدم (للرضع)، وشحمة الأذن، والجبهة، وجسر الأنف. من المهم استخدام المستشعر المناسب للموقع المقصود.

FINGER PULSE OXIMETER



HANDHELD PULSE OXIMETER



TABLETOP PULSE OXIMETER



WRIST-WORN PULSE OXIMETER



PEDIATRIC PULSE OXIMETERS



> معدات

- 1- مقياس التأكسد.
- 2- مسبار مقياس التأكسج مناسب للمريض وموصى به من قبل الشركة المصنعة لمقياس التأكسج.
- 3- مزيل الأسيتون أو طلاء الأظافر إذا لزم الأمر.
- 4- ورقة تدفق القلم والعلامات الحيوية أو السجل الصحي الإلكتروني (EHR).

التدخلات	اسبو2
• يعتبر طبيعيًا ولا يتطلب عمومًا أي تدخل جراحي تدخل. • مواصلة المراقبة الروتينية للمريض.	95% ≤
• يعتبر حدوديًا. • تقييم وضبط موضع المسبار. • ابدأ بالأكسجين بمعدل 2 لتر/دقيقة معيارًا إلى $SpO_2 < 95\%$.	94%–91%
• رفع الرأس وتشجيع المريض على السعال والتنفس بعمق. • تقييم مجرى الهواء والشفط حسب الحاجة. • إعطاء الأكسجين ومعايرته إلى $SpO_2 < 95\%$. • إذا فشلت الحالة في التحسن، ساعد في التهوية يدويًا و الاستعداد للتنبيب.	90%–85%
• إعطاء الأكسجين بنسبة 100%، ووضع المريض في وضع مستقيم، وتشجيع السعال والتنفس العميق، والشفط حسب الحاجة. • مساعدة عمليات التهوية يدويًا والاستعداد للتنبيب إذا فشلت الحالة في التحسن. • ضع في اعتبارك عوامل الانعكاس للجهاز التنفسي المحتمل الناجم عن الأدوية اكتئاب.	85% >

> الحالات التي قد تؤدي إلى قراءات خاطئة

✓ قراءات عالية كاذبة

1- فقر الدم.

2- قلاء.

3- التسمم بثاني أكسيد

الكربون. 4- نقص حجم الدم.

5- حركة المريض.

✓ قراءات منخفضة كاذبة

1- أطراف باردة.

2- الأدوية (مضيقات الأوعية).

3- طلاء الأظافر/عدوى

الأظافر. 4- حركة المريض.

5- ضعف الدورة الدموية

الطرفية. 6- مرض رينو.

> إجراء

خطوات	عقلاني
1. مراجعة السجل الصحي لأي صحة تحديد العوامل المؤثرة يساعد في ذلك المشاكل التي من شأنها أن تؤثر على تفسير المريض للنتائج. حالة الأوكسجين.	
2. احضر المعدات اللازمة.	إن إحضار كل شيء إلى جانب السرير يوفر الوقت والطاقة.
3. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا كانت نظافة اليدين ومعدات الوقاية الشخصية تمنع ذلك.	انتشار الكائنات الحية الدقيقة.
4. التعرف على المريض.	للتأكد من أن المريض المناسب يتلقى التدخل الصحيح.
5. أغلق الستائر حول السرير وأغلقها للحفاظ على الخصوصية وتقليل عدد المرضى باب الغرفة إن أمكن. اشرح قلقك. الإجراء.	
6. تقييم العلامات والأعراض	تشير العلامات والأعراض الجسدية إلى تشيع الأكسجين غير طبيعي.
التغيرات في تشيع الأكسجين (على سبيل المثال، تغير معدل التنفس، أو العمق، أو الإيقاع؛ أصوات التنفس العرضية؛ الأظافر المزرقّة أو الشفاه أو الأغشية المخاطية أو الجلد؛ الأرق؛ صعوبة في التنفس).	
7. تقييم ل عوامل ذلك	التأثير يسمح للممرضة بتقييم الأكسجين
قياس SpO2 (على سبيل المثال، اختلافات تشيع الأكسجين بدقة. العلاج، العلاج التنفسي مثل الوضعي تصريف المياه و قرع، الهيموجلوبين المستوى، انخفاض ضغط الدم، درجة الحرارة و طلاء الأظافر والأدوية مثل موسعات الشعب الهوائية).	
8. تحديد المريض الأكثر ملاءمة- موقع محدد (على سبيل المثال، الإصبع، شحمة الأذن، جسر الأنف، الجبهة) لوضع مسبار الاستشعار عن طريق قياس وقت إعادة ملء الشعيرات الدموية. إذا كان وقت إعادة ملء الشعيرات الدموية أقل من ثانيتين، حدد موقعًا بديلًا.	تنعكس التغيرات في مستوى SpO2 في الدورة الدموية لأسرة الشعيرات الدموية في الأصابع في غضون 30 ثانية وفي أسرة الشعيرات الدموية في شحمة الأذن في غضون 5 إلى 10 ثوان.
	

9. قم بتوصيل المستشعر بموقع المراقبة. في حالة استخدام تحديد موقع المستشعر بناءً على الأجهزة الطرفية الإصبع، قم بإزالة طلاء الأظافر من الدورة الدموية للأصابع ودرجة حرارة الأطراف. مع الأسيتون أو مزيل الطلاء.



10. بمجرد تثبيت المستشعر في مكانه، قم بتشغيل مقياس الأكسجين عن طريق تنشيط الطاقة.



11. اترك المستشعر في مكانه لمدة تتراوح من 10 إلى 30 ثانية. تستغرق القراءة عادةً من 10 إلى 30 ثانية، أو حتى تصل قراءة مقياس التأكسج إلى مستوى ثابت اعتمادًا على الموقع المحدد. تصل القيمة وعرض النبض إلى الحد الأقصى قوة.



12. إذا كنت تخطط لمراقبة الأكسجين التحقق بشكل مستمر من حدود إنذار SpO2 المحددة مسبقًا من قبل الشركة المصنعة عند مستوى منخفض يبلغ 85% وأعلى من 100%.

13. مقارنة قراءة SpO2 مع المريض يسمح للممرضة بتقييم التغيير في الحالة الأساسية السابقة والمقبولة للمريض SpO2 ووجود قيم.

14. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. أداء اليد صحة.

يجب ضبط إنذارات التشيع على المستوى المناسب حدود وأحجام لتجنب تخويف المرضى والزوار.

تغير الجهاز التنفسي.

يقلل من انتشار الكائنات الحية الدقيقة.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	محاكمة 3	تعليق
1. مراجعة السجل الصحي بحثًا عن أي مشاكل صحية وهذا من شأنه أن يؤثر على أكسجة المريض حالة.					
2. احضر المعدات اللازمة.					
3. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنِشِر إليه.					
4. التعرف على المريض.					
5. أغلق الستائر حول السرير وأغلقها باب الغرفة إن أمكن. اشرح إجراء.					
6. تقييم علامات وأعراض التغيرات في تشبع الأكسجين (على سبيل المثال، تغير معدل التنفس أو العمق أو الإيقاع؛ أصوات التنفس العرضية؛ الأظافر المزرقة، الشفاه، المخاط الأغشية أو الجلد؛ الأرق؛ الصعوبة تنفس).					
7. تقييم ل عوامل ذلك تأثير قياس SpO2 (على سبيل المثال، العلاج بالأكسجين العلاج التنفسي مثل التصريف الوضعي و قرع، الهيموجلوبين المستوي، انخفاض ضغط الدم ودرجة الحرارة وطلاء الأظافر و الأدوية مثل موسعات الشعب الهوائية).					
8. تحديد الموقع المناسب للمريض لوضع مسبار الاستشعار عن طريق قياس وقت إعادة ملء الشعيرات الدموية. إذا كان وقت إعادة ملء الشعيرات الدموية أقل من ثانيتين، حدد موقعًا بديلًا.					
9. قم بتوصيل المستشعر بموقع المراقبة. إذا كنت تستخدم إصبع، قم بإزالة طلاء الأظافر.					
10. بمجرد وضع المستشعر في مكانه، قم بتشغيل مقياس الأكسجين عن طريق قوة التنشيط.					
11. اترك المستشعر في مكانه لمدة تتراوح من 10 إلى 30 ثانية أو حتى تصل قراءة مقياس الأكسجين إلى قيمة ثابتة ويصل عرض النبض إلى قوته الكاملة.					
12. التحقق من حدود إنذار SpO2 المحددة مسبقًا من قبل الشركة المصنعة عند مستوى منخفض يبلغ 85% ومستوى مرتفع يبلغ 100%.					
13. مقارنة قراءة SpO2 مع المريض خط الأساس السابق وSpO2 المقبول قيم.					
14. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. أداء اليد صحة.					

> اعتبارات التمريض

- 1- يمكن تفويض قياس تشبع الأكسجين باستخدام مقياس التأكسج النبضي إلى موظفي التمريض المساعدين.
- 2- تقييم درجة حرارة جلد المريض ولونه، بما في ذلك لون أسرة الأظافر. تعتبر درجة الحرارة مؤشرا جيدا لتدفق الدم.
- 3- استمع إلى الرئتين. لاحظ كمية الأكسجين وطريقة توصيله إذا كان المريض يتلقى أكسجينا إضافيا.
- 4- تعليمات بإخطار الممرضة على الفور بأي قراءة أقل من SpO2 بنسبة 95% أو قيمة لمريض معين.
- 5- تعليمات لمنع استخدام قياس التأكسج النبضي للحصول على معدل ضربات القلب لأن مقياس التأكسج لن يكتشف نبضا غير منتظم.

الحصول على تخطيط القلب الكهربائي (ECG)

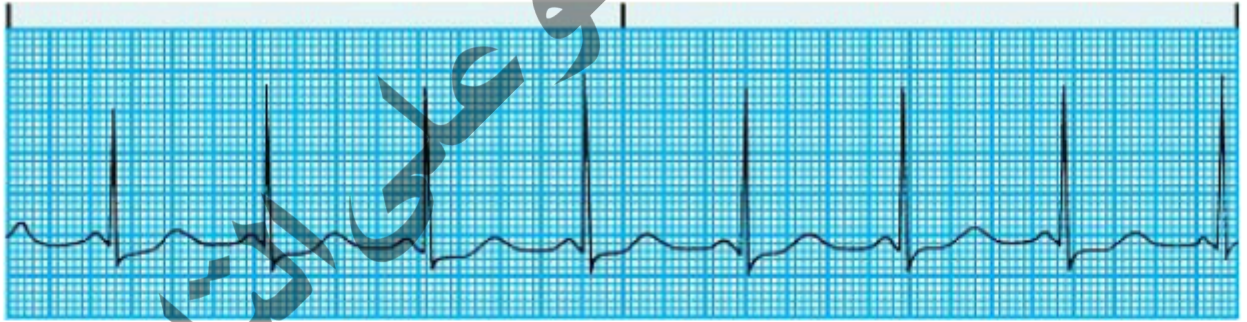
الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف تخطيط القلب النبضي (ECG).
- تحديد هدف الحصول على تخطيط القلب (ECG).
- تعداد مسار التوصيل.
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تحديد موضع أسلاك الصدر والأطراف.
- إظهار إجراء تخطيط كهربية القلب (ECG).

تعريف

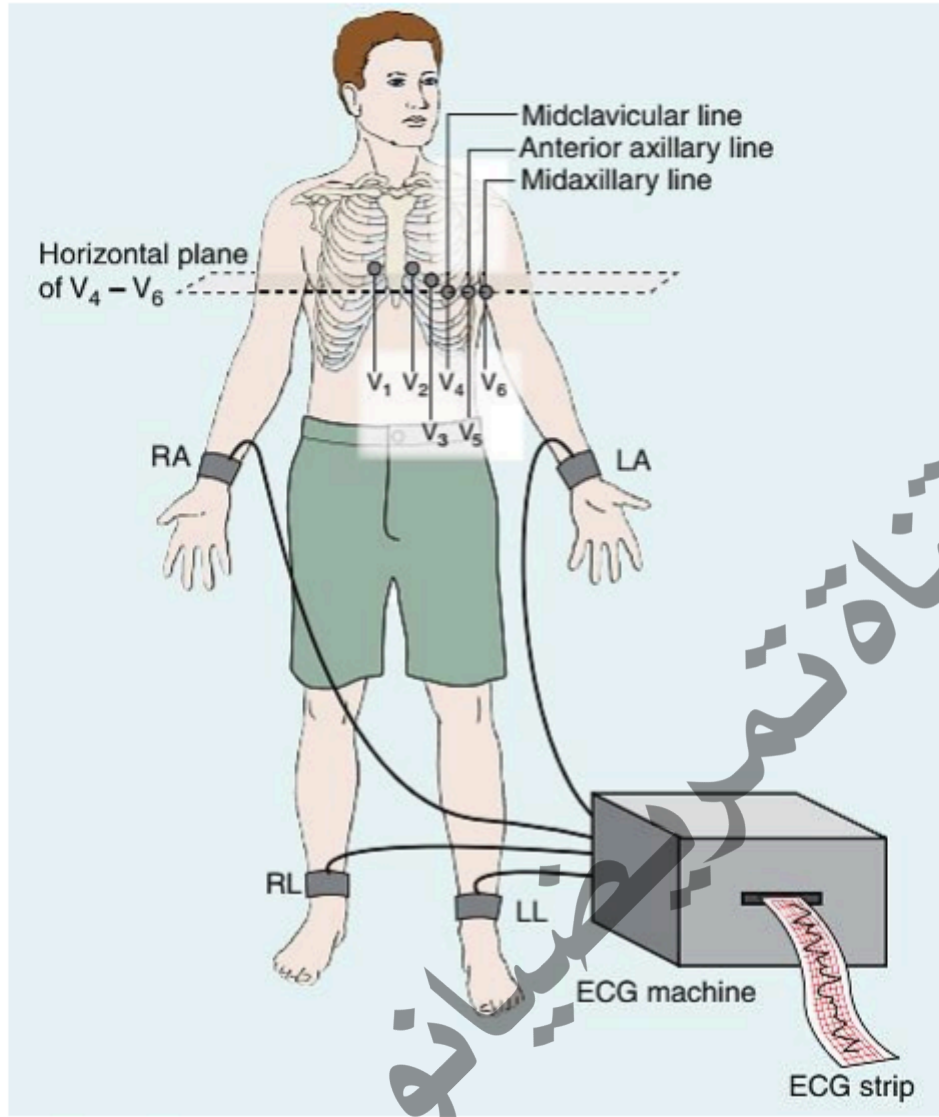
- تخطيط كهربية القلب "ECG" [يُختصر أيضًا باسم EKG في بعض المراجع] هو أحد أدوات التشخيص الأكثر قيمة والأكثر استخدامًا. يقيس تخطيط القلب النشاط الكهربائي للقلب.
- إن النبضات التي تتحرك عبر نظام التوصيل في القلب تخلق تيارات كهربائية يمكن مراقبتها على سطح الجسم. يمكن للأقطاب الكهربائية المثبتة على الجلد اكتشاف هذه التيارات الكهربائية ونقلها إلى جهاز ينتج سجلًا، وهو مخطط كهربية القلب، لنشاط القلب. يتم رسم البيانات بيانياً على شكل أشكال موجية.



شريط تخطيط القلب (شكل الموجة)

الهدف من الحصول على تخطيط القلب (ECG).

- يمكن استخدام تخطيط القلب لتحديد نقص تروية عضلة القلب واحتشاءها، واضطرابات الإيقاع والتوصيل، وتضخم الغرفة، واختلال توازن الكهارل، وسمية الدواء.
- يستخدم تخطيط كهربية القلب القياسي المكون من 12 سلكًا سلسلة من الأقطاب الكهربائية الموضوعة على الأطراف و جدار الصدر لتقييم القلب من 12 وجهة نظر مختلفة (أسلاك) عن طريق ربط عشرة كابلات بأقطاب كهربائية بأطراف المريض وصدره: أربعة أقطاب كهربائية للأطراف وستة أقطاب الصدر

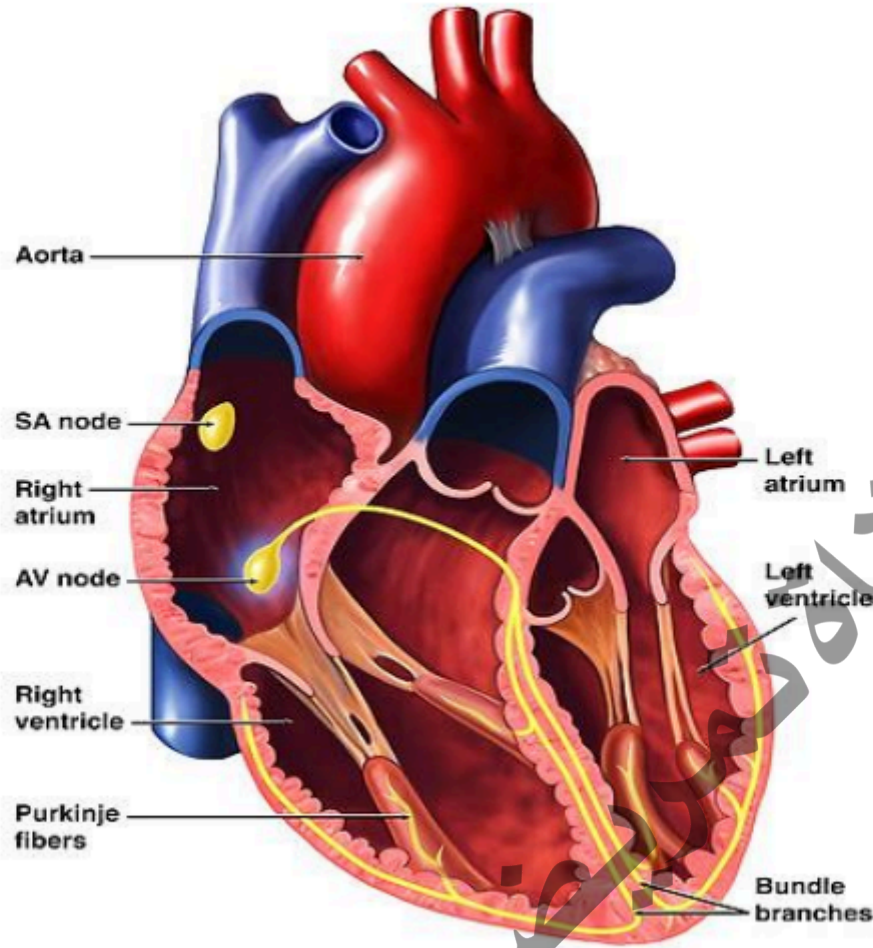


➤ الجهاز الموصل للقلب

- التوصيل القلبي هو المسار الذي يقوم القلب من خلاله بتوصيل النبضات الكهربائية. تؤدي هذه النبضات إلى انقباض القلب ثم استرخائه. تؤدي الدورة المستمرة لتقلص عضلة القلب متبوعة بالاسترخاء إلى ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

✓ يتكون مسار التوصيل من خمسة عناصر:

- 1 - العقدة الصينية الأذينية (SA)، 2 - العقدة الأذينية البطينية (AV)، 3 - حزمة هيس، 4 - فروع الحزمة اليسرى واليمنى، 5 - ألياف بوركينجي.



➤ معدات

- 1- جهاز تخطيط القلب. 2- ورق تسجيل. 3- أقطاب كهربائية مسبقة التجلط يمكن التخلص منها. 4- مسحات مزيل المادة اللاصقة. 5- 4 × 4 وسادات شاش. 6- منظف البشرة والماء إذا لزم الأمر. 7- معدات الوقاية الشخصية الإضافية، كما هو موضح. 8- مقصات الشعر (اختيارية حسب الشعر في مواقع الأقطاب الكهربائية). 9- بطانية حمام.

➤ وضع أسلاك الصدر والأطراف

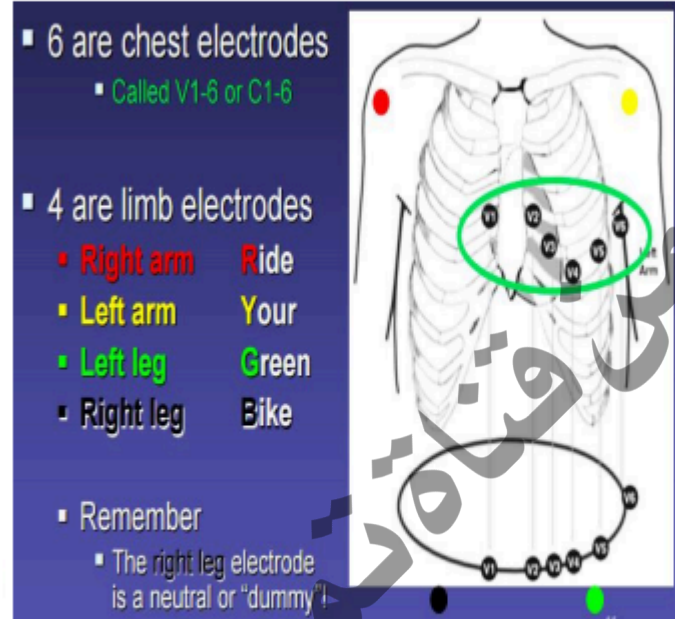
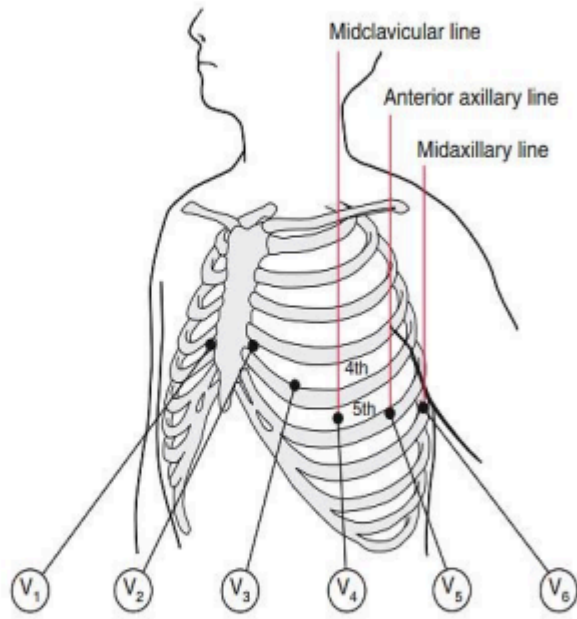
أسلاك الصدر

V1 – 4 في الفضاء الوربي (ICS) في الزاوية القصية اليمنى. V2 – 4 ث ICS على الحدود القصية اليسرى. V3 – منتصف الطريق بين V2 و V4. V4 ث ICS عند خط منتصف الترقوة. V5 – الخط الإبطي الأمامي الأيسر عند مستوى V4 أفقيًا. V6 – خط منتصف الإبط الأيسر عند مستوى V4 أفقيًا.

خيوط الأطراف

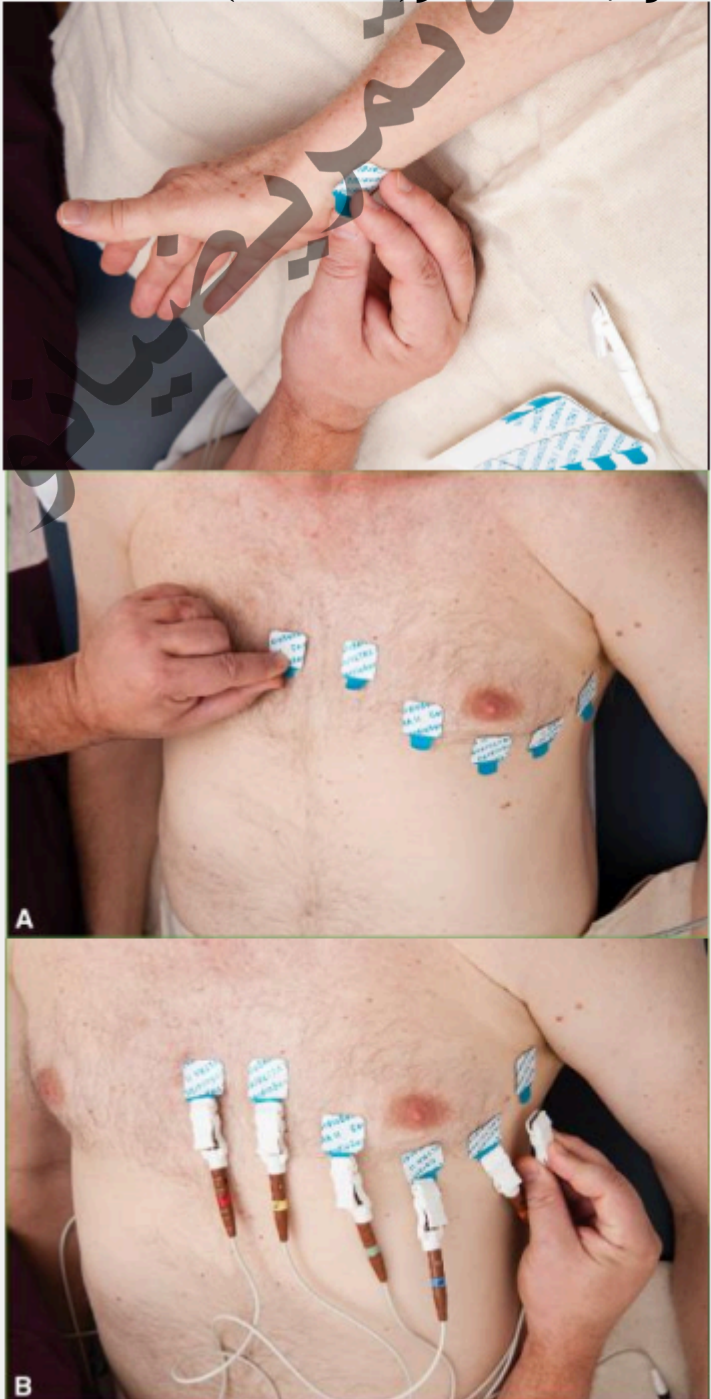
RA = الذراع اليمنى. LA = الذراع الأيسر.

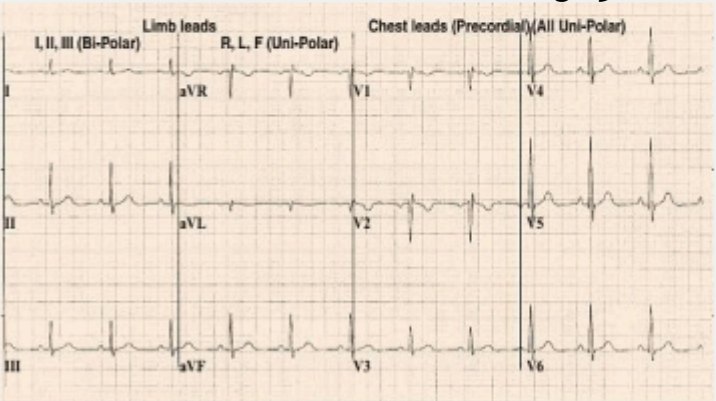
RL = الساق اليمنى.
LL = الساق اليسرى.



➤ إجراء

خطوات	عقلاني
1. التحقق من ترتيب تخطيط القلب لدى المريض وهذا يضمن صحة السجل الطبي.	يتم التدخل على المريض الصحيح.
2. جمع كافة المعدات.	يوفر تجميع المعدات نهجًا منظمًا لـ مهمة.
3. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا كانت نظافة اليدين ومعدات الوقاية الشخصية تمنع ذلك.	انتشار الكائنات الحية الدقيقة.
4. التعرف على المريض.	إن تحديد هوية المريض يضمن الحق في المريض مستقبل التدخل ويساعد على الوقاية أخطاء.
5. أغلق الستائر حول السرير وأغلقها للحفاظ على الخصوصية وتقليل عدد المرضى باب الغرفة إن أمكن. عندما قمت بإعداد القلق الجهاز لتسجيل تخطيط القلب الكهربائي المكون من 12 سلكًا، اشرح الإجراء للمريض.	إن توفر المعدات يوفر وقت و تيسير إنجاز المهمة.
6. ضع جهاز تخطيط القلب بالقرب من جهاز المريض السرير، وقم بتوصيل سلك الطاقة بالحائط مخرج.	
7. إن جعل المريض يستلقي مستلقيًا في وسط الوضع المناسب يساعد على الزيادة سرير مع الذراعين على الجانبين. ارفع رأس المريض المريح وسوف ينتج عنه من السرير إذا لزم الأمر لتعزيز الراحة. تتبع أفضل. تحديد المواقع المناسبة كشف ذراعي المريض وساقيه، ولف واسترخاء الذراعين والساقين بشكل مناسب. تشجيع المريض على الاسترخاء يقلل من توتر العضلات و الذراعين والساقين. تأكد من عدم وجود معصمين	

كهربائي و تدخل.	المس الخصر. تأكد من أن القدمين لا ترتجفان المس لوح قدم السرير.
مع التحضير المناسب للبشرة من قبل أقطاب كهربائية تكون وضع يقلل بشكل مفرط من مقاومة الجلد و ضوضاء الإشارة، الحلاقة تسبب ميكرو سحجات على جلد الصدر.	8. تنظيف وتجهيز منطقة القطب المعزولة الصابون والماء. امسح المنطقة بقطعة قماش خشنة أو شاش. إذا كانت المنطقة مشعرة، قم بقص الشعر. لا تحلق شعرك.
ل دقيق	9. ضع الأقطاب الكهربائية في المواضع الصحيحة. تم وضع الأسلاك بشكل صحيح مباشرة على جدار الصدر وليس الثدي مهم معدل. قد يحتاج الثدي إلى الرفع لتفسير تخطيط القلب الكهربائي المكون من 12 سلغًا. تستوعب أسلاك الصدر (V4، V5، V6). 

يقلل من الآثار الكهربائية و يحسن الجودة والدقة تخطيط القلب	10. بعد تطبيق جميع الخيوط، تأكد أن الكابلات لا تسحب الأقطاب الكهربائية أو تقع فوق بعضها البعض. تأكد من ضبط محدد سرعة الورق على المستوى القياسي 25 متر/ثانية وأن الآلة مضبوطة على الجهد الكامل، 10 مللي فولت. 
يسمح ل مناسب تحديد شريط تخطيط القلب.	11. إذا لزم الأمر، أدخل المريض المناسب هذا بيانات التعريف في الجهاز.
مراقبة جودة التتبع يسمح بإجراء التعديلات، إذا لزم الأمر.	12. اضغط على الزر AUTO. لاحظ التتبع نوعي. سيقوم الجهاز بتسجيل جميع الخيوط الـ 12 تلقائيًا، وتسجيل 3 خيوط متتالية في وقت واحد. 
	13. عندما تنتهي الآلة من تسجيل 12- تعزيز الإزالة والتنظيف قم بإجراء تخطيط كهربائي للقلب، ثم قم بإزالة الأقطاب الكهربائية وتنظيف راحة المريض. جلد المريض. 

14. بعد فصل أسلاك التوصيل عن الأقطاب الكهربائية، تخلص منها. ضع المريض في وضع مريح.	التخلص السليم يمنع انتشار إرجاع الكائنات الحية الدقيقة. تحديد المواقع مع تعديل الرأس يعزز المريض الراحة.
15. تنظيف جهاز تخطيط القلب.	تنظيف معدات بين استخدامات المريض تقلل من خطر الإصابة انتقال الكائنات الحية الدقيقة.
16. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. أداء نظافة اليدين.	إزالة معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح يقلل خطر انتقال العدوى وتلوث العناصر الأخرى.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	محاكمة 3	تعليق
1. التحقق من ترتيب رسم القلب الكهربائي للمريض السجل الطبي.					
2. جمع كافة المعدات.					
3. قم بإجراء نظافة اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية، إذا مُنِشِر إليه.					
4. التعرف على المريض.					
5. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إن أمكن. كما قمت بالإعداد الجهاز لتسجيل تخطيط القلب الكهربائي المكون من 12 سلغًا، اشرح الإجراء للمريض.					
6. ضع جهاز تخطيط القلب بالقرب من سرير المريض، وقم بتوصيل سلك الطاقة بالحائط مخرج.					
7. اطلب من المريض الاستلقاء في وسط سرير مع الذراعين على الجانبين. ارفع الرأس من السرير إذا لزم الأمر لتعزيز الراحة. كشف ذراعي المريض وساقيه، والستارة بشكل مناسب.					
8. قم بتنظيف وتحضير منطقة القطب المعزولة بالماء والصابون. لا تحلق شعرك.					
9. ضع الأقطاب الكهربائية في المواضع الصحيحة. وضع مباشرة على جدار الصدر وليس الثدي منديل. قد يحتاج الثدي إلى الرفع تستوعب أسلاك الصدر (V4، V5، V6). • V1—المسافة بين الضلع الرابع (ICS) على اليمين الحدود القصية. الإناث: اختر موقعًا قريبًا إلى الوضع القياسي قدر الإمكان. • V2—4th ICS عند الحدود القصية اليسرى. • V3—في منتصف الطريق بين V2 و V4. • V4—5th ICS عند خط منتصف الترقوة.					

					• V5—خط الإبط الأمامي الأيسر عند مستوى V4 أفقيًا. • V6—خط منتصف الإبط الأيسر عند مستوى V4 أفقيًا
					10. تأكد من أن الكابلات لا تسحب الأقطاب الكهربائية أو تقع فوق بعضها البعض. تأكد من ضبط معدل سرعة الورق على المستوى القياسي 25 متر/ثانية وأن الآلة هي ضبط على كامل الجهد 10 مللي فولت.
					11. إذا لزم الأمر، أدخل المريض المناسب بيانات التعريف في الجهاز.
					12. اضغط على الزر AUTO. راقب جودة التتبع. سيقوم الجهاز بتسجيل جميع العملاء المحتملين الـ 12 تلقائيًا، وتسجيل 3 عملاء محتملين متتاليين التزامن.
					13. عندما تنتهي الآلة من تسجيل تخطيط كهربية القلب المكون من 12 سلًا، قم بإزالة الأقطاب الكهربائية و تنظيف بشرة المريض.
					14. بعد فصل أسلاك التوصيل عن الأقطاب الكهربائية، تخلص من الأقطاب الكهربائية. يعود وضع المريض في وضع مريح.
					15. تنظيف جهاز تخطيط القلب.
					16. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. قم بإجراء نظافة اليدين.

➤ اعتبارات التمريض

- 1- لا يتم تفويض الحصول على تخطيط القلب إلى موظفي التمريض المساعدين.
- 2- قم بمراجعة السجل الطبي للمريض وخطة الرعاية للحصول على معلومات حول حاجة المريض إلى تخطيط القلب.
- 3- تقييم الحالة القلبية للمريض، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وضغط الدم، والاستماع إلى أصوات القلب.
- 4- إذا كان المريض متصلًا بالفعل بجهاز مراقبة القلب، فقم بإزالة الأقطاب الكهربائية استيعاب الخيوط السابقة للقلب وتقليل التداخل الكهربائي في تتبع تخطيط القلب.
- 5- أبقِ المريض بعيدًا عن الأشياء التي قد تسبب تداخلًا كهربائيًا، مثل المعدات والتركيبات وأسلاك الطاقة.
- 6- افحص صدر المريض بحثًا عن مناطق التهيج أو الانهيار أو الشعر الزائد الذي قد يتداخل مع وضع القطب الكهربائي.

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

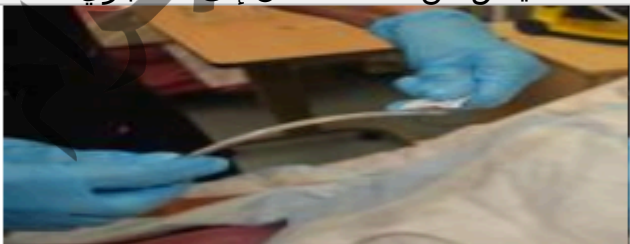
- تعريف التغذية عن طريق الأنبوب الأنفي المعدي.
- تحديد هدف التغذية بالأنبوب الأنفي المعدي.
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تطبيق التغذية الأنبوبية الأنفية المعوية.

التعريف: التغذية الأنفية المعوية (NG) هي المكان الذي يتم فيه وضع أنبوب تغذية ضيق من خلال أنفك إلى معدتك. يمكن استخدام الأنبوب لإعطاء السوائل والأدوية والأطعمة السائلة المليئة بالعناصر الغذائية مباشرة إلى معدتك. > خطوات إدخال الأنبوب الأنفي المعدي

اعتبارات السلامة:

- قم بتنظيف اليدين.
- قدم نفسك للمريض.
- تأكيد هوية المريض باستخدام معرفين للمريض (على سبيل المثال، الاسم وتاريخ الميلاد).
- شرح العملية للمريض.
- استمع إلى إشارات المريض وانتبه إليها.
- ضمان خصوصية المريض وكرامته.

خطوات	معلومات إضافية
لوازم.	الكائنات الحية الدقيقة
2. فحص حالة بصريا تجاوب الأنف والفم.	فحص المريض بحثًا عن علامات العدوى أو الجلد انهيار.
يبدأ. يمكنك القيام بذلك عن طريق إغلاق أحد الجانبين وطلب من المريض الشم. اسأل المريض عن إصابات سابقة أو تاريخ من انحراف الحاجز الأنفي.	فتحة الأنف الأقرب إلى الشفط.
4. جس بطن المريض انتفاخ، ألم، و/أو الاستماع إلى أصوات الأمعاء.	نتائج تقييم الوثائق و صلابة. تحديد مدى ملاءمة أنبوب NG الإدراج المتعلق بسبب الإدراج و التقييم البدني للمريض.
وفهم الإجراء.	متعلق بإدخال NG للسماح بـ

مرور الأنبوب عبر الأنف و الجهاز الهضمي.	
التحقق من الطلبات المناسبة ذات الصلة أمان.	6. تحقق من أوامر الطبيب لمعرفة نوع الأنبوب الذي يجب وضعه وسبب وضع المريض
7. تحقق من أوامر الطبيب لتحديد ما إذا كان هذا يجب أن يكون متناسبًا مع	ما إذا كان سيتم ربط أنبوب NG بالسبب الخاص بأنبوب NG. شفط أو كيس تصريف.
90 وهذا يسمح لأنبوب NG بالمرور بسهولة أكبر عبر البلعوم الأنفي وإلى المعدة.	8. ضع المريض جالسًا بزاوية 45 درجة (ما لم يكن ذلك موانعًا بسبب حالة المريض)، مع وضع وسادة تحته الرأس والكتفين.
مقدم الرعاية الصحية.	ارتفاع.
وقد تكون إفرازات الأنف والفم واضحة أثناء الإجراء.	10. ضع منشفة على صدر المريض توفير أنسجة الوجه وحوض القيء.
مرور حوض الغاز الطبيعي	مقيد.
سوف تستخدم يدك المهيمنة للإدخال الأنبوب.	12. قف على الجانب الأيمن للمريض إذا كنت تستخدم يدك اليمنى الأنبوب. أعسر.
 القياس من طرف الأنف إلى شحمة الأذن  القياس من شحمة الأذن إلى الخنجري	13. قياس مسافة الأنبوب من طرف الأنف، إلى... شحمة الأذن، إلى... الناتئ الخنجري ثم قم بوضع علامة على الأنبوب عند هذه النقطة.
	14. قم بتشعيم طرف أنبوب NG

	15. قم بثني 10 إلى 15 سم من نهاية أنبوب NG حول إصبعك المغطى بالقفاز، ثم أطلق سراحه.
لف أنبوب NG حول إصبعك يساعدها على التوافق مع المنحنى الطبيعي لـ البلعوم الأنفي.	16. اطلب من المريض أن ينزل رأسه للأمام ويتنفس من خلال الفم.
يؤدي إسقاط الرأس للأمام إلى إغلاق القصبة الهوائية وفتح المريء، مما يسمح لأنبوب NG بالمرور بسهولة أكبر عبر البلعوم الأنفي إلى المعدة	17. أدخل طرف أنبوب NG ببطء في فتحة أنف المريض وتقدمها بثبات، في اتجاه هبوطي، على طول الجزء السفلي من الممر الأنفي ذو النهاية المنحنية مشيراً إلى الأسفل في اتجاه الأذن على نفس جانب فتحة الأنف.
	18. قد تشعر بمقاومة طفيفة أثناء تقدمك على طول الممر الأنفي. قم بلف الأنبوب قليلاً، ثم اضغط لأسفل، واستمر في محاولة دفع الأنبوب للأمام. إذا شعرت بمقاومة كبيرة، قم بإزالة الأنبوب واترك المريض يستريح من قبل حاول مرة أخرى في فتحة الأنف الأخرى.
تقدم الأنبوب بلطف	19. إذا كانت هناك صعوبة في تمرير NG إذا استمر المريض في الكمامة أو السعال، تحقق من الأنبوب، يمكنك أن تطلب من المريض احتساء الماء حتى لا يكون الأنبوب ملفوفاً في الجزء الخلفي من الأنبوب ببطء من خلال القشة ما لم يكن هناك سوائل فموية، باستخدام شفرة اللسان و
مسموح، اطلب من المريض أن يجرب الجفاف البلع أثناء تحريك الأنبوب.	20. استمر في تقدم أنبوب NG حتى تصل إلى الوصول إلى العلامة/الشريط الذي وضعته قياس.
وهذا يضمن وضعًا دقيقًا.	خد المريض بقطعة من الشريط حتى أثناء التحقق من موضعه يمكنك التحقق من الموضع الصحيح.
	22. التحقق من وضع الأنبوب وفقاً لسياسة الوكالة.
يجب أن تكون المحتويات المستنشقة من الأنبوب حمضية بدرجة حموضة >5. إذا كان الرقم الهيدروجيني هو أكثر من 6، قد يشير إلى وجود	

عادةً ما يتم استخدام ورق الأس الهيدروجيني المرمز بالألوان، وهو فحص أولي ومؤقت، للتأكد من وجود محتويات حمضية. ثم يتم أخذ الأشعة السينية للتأكد من وضعها مسبقًا لاستخدام أنبوب NG للتغذية.	كما هو الحال بالنسبة لسوائل الجهاز التنفسي أو محتوى الأمعاء الدقيقة، ويجب إزالة الأنبوب.
علامة) وتسجيل طول هجرة الأنبوب. تمتد من الأنف إلى الطرف الخارجي الأنبوب.	23. بمجرد تحديد موضع الأنبوب، يساعد هذا في التعرف عليه في الوقت المناسب وتأكيده، ووضع علامة (مع تحديد دائم لإزالة الأنبوب أو
24. قم بتثبيت الأنبوب على ثوب المريض باستخدام دبوس أمان، مما يسمح بوجود أنبوب كافٍ الطول لحركة الرأس بشكل مريح.	
سياسة الوكالة، والإبلاغ عن أي أمر غير متوقع يعزز سلامة المرضى النتائج المتعلقة بالرعاية الصحية المناسبة مزود.	25. قم بتوثيق الإجراء وفقًا للتوثيق الدقيق وفي الوقت المناسب

تغذية الأنبوب

تحضير التغذية بالأنبوب:

- قم بتخزين المنتجات غير المفتوحة في درجة حرارة الغرفة، وليس في ضوء الشمس المباشر.
- اغسل يديك قبل التعامل مع المنتجات.
- رج العلبة أو الزجاجات جيدًا ثم امسح الجزء العلوي جيدًا قبل فتحها.
- إعطاء التغذية عندما يكون المنتج في درجة حرارة الغرفة.
- قم بتغطية أي منتج غير مستخدم وقم بتخزينه في الثلاجة.
- قم بتخزين المنتج لمدة أقصاها 24 ساعة؛ إذا لم يتم استخدامه، تخلص من الباقي.

الإمدادات التي يجب جمعها:

- يجب توصيل التغذية الأنبوبية الصحيحة (علبة أو زجاجة تعمل على مدار 24 ساعة)
- مضخة التغذية (في حالة التغذية الأنبوبية المستمرة)
- مجموعة التغذية (مجموعة الأكياس أو مجموعة المسامير)

- حقنة 60 مل - ماء 50 مل - حاوية متدرجة

مواضع استقبال التغذية الأنبوبية:

- الخيار 1: الاستلقاء في السرير أو على الأريكة في وضع نصف الجلوس مع رفع الرأس بمقدار 30 درجة على الأقل.
- الخيار الثاني: الجلوس على الكرسي.

إجراء التغذية بالأنبوب:

- غسل اليدين.
- تقييم البطن من حيث الانتفاخ.
- ارفع رأس السرير إلى 30 درجة على الأقل.
- أدخل حقنة سعة 60 مل في المنفذ واسكب منتج التغذية في المحقنة.
- أضف التركيبة لتصريفها بالجاذبية.
- أضيفي المزيد من التركيبة حتى تحصلي على الكمية المطلوبة.
- اغسلي بـ 50 مل من الماء.
- قم بتغطية الأنبوب.

-البقاء في وضع مستقيم لمدة ساعة على الأقل بعد الرضاعة.

-شطف المعدات جيدا.

تنظيف موقع الأنبوب والمعدات:

-يجب تنظيف الموقع يوميا بالماء والصابون.

-قم بالعناية بالموقع حسب أوامر الطبيب.

-يمكن تنظيف مجموعات أكياس التغذية الأنبوية بالماء والصابون.

-تأكد من تمرير الماء والصابون عبر الأنابيب أيضًا.

-مجموعات أكياس التغذية الأنبوية جيدة طالما بقيت سليمة.

-اشطفه بالماء للتأكد من خروج كل الصابون من الكيس والأنابيب.

-يمكن تنظيف الحقن بالماء والصابون أو وضعها في غسالة الأطباق على الرف العلوي.

-ويمكن أيضًا استخدامها طالما ظلت سليمة.



عند العمل مع المرضى الذين لديهم أنابيب أنفية معدية، تذكر تدابير الرعاية التالية:

-الحفاظ على الراحة وتعزيزها. يسبب الأنبوب تهيجًا مستمرًا للغشاء المخاطي للأنف، مما يسبب قدرًا كبيرًا من الانزعاج. تأكد من تثبيت الأنبوب بشكل آمن على أنف المريض لمنع حركة الأنبوب الزائدة، وتثبيته على الثوب لتجنب السحب أو السحب المفرط.

- بسبب انسداد إحدى فتحتي الأنف، يميل المرضى إلى التنفس عن طريق الفم. يؤدي هذا إلى جفاف الغشاء المخاطي للأنف والفم، وسيشتكي المرضى من العطش، لكنهم عادة ما يكونون NPO (لا شيء عن طريق الفم). العناية بالفم تساعد على تخفيف الجفاف. يمكن أن يشمل ذلك شطف الفم بالماء البارد أو غسول الفم طالما أن المريض لا يبلع. قد يُسمح لبعض المرضى بمص رقائق الثلج.

-إذا اشتكى المريض من آلام في البطن أو انزعاج أو غثيان أو بدأ بالتقيؤ، يجب الإبلاغ عن ذلك على الفور. من المحتمل أن يكون تدفق الصرف مسدودًا وسيحتاج الأنبوب إلى الري.

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف الحقنة الشرجية.
- تحديد أنواع الحقنة الشرجية.
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تطبيق إجراء الحقنة الشرجية.

تعريف:

الحقنة الشرجية هي حقن السائل في المستقيم والقولون عن طريق فتحة الشرج.

أنواع الحقنة الشرجية:

- الحقن الشرجية المطهرة: تعطى لإزالة البراز من القولون.
- الحقن الشرجية التي تعمل على احتباس الزيت: تساعد على تليين البراز والغشاء المخاطي المعوي، مما يجعل عملية التغوط أسهل.
- الحقن الشرجية الكارميناتية: تساعد على طرد الغازات من المستقيم وتخفيف التمدد الثانوي للغازات.
- الحقن الشرجية الطبية: تستخدم لإعطاء الدواء عن طريق المستقيم.
- الحقن الشرجية المضادة للديدان: يتم إعطاؤها لتدمير الطفيليات المعوية.

المعدات:

- محلول الحقنة الشرجية (يختلف حسب سبب الحقنة الشرجية)، وغالبًا ما يكون عبارة عن محاليل معبأة مسبقًا ومعدة تجاريًا
- قفازات غير معقمة • معدات الوقاية الشخصية الإضافية، كما هو موضح
- وسادة مقاومة للماء
- بطانية حمام • منشفة ومنظف للبشرة ومنشفة
- حوض النوم.
- مناديل المرحاض
- مادة تشحيم قابلة للذوبان في الماء

خطوات	الأساس المنطقي
1- التحقق من ترتيب الحقنة الشرجية. جمع المعدات.	التحقق من الأمر الطبي أمر بالغ الأهمية ل التأكد من أن الحقنة الشرجية مناسبة يتم إعطاؤه للمريض المناسب.
2- قم بنظافة اليدين وارتدائها معدات الحماية الشخصية، إذا لزم الأمر.	نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة.
3. التعرف على المريض.	إن تحديد هوية المريض يضمن حصول المريض المناسب على التدخل و يساعد على منع الأخطاء.
4. أشرح الإجراء للمريض.	توضيح تيسير مريض التعاون ويقلل من القلق.
5. قم بتجميع المعدات على طاولة فوق السرير في متناول اليد.	ترتيب العناصر القريبة أمر مريح، يوفر الوقت، ويتجنب التمدد والالتواء غير الضروريين للعضلات من جانب الممرضة.
- قم بتسخين محلول الحقنة الشرجية للجسم أ درجة الحرارة عن طريق وضع الحاوية في وعاء من الماء الدافئ.	يمكن أن يسبب المحلول البارد أمراضًا معوية التشنج.
6. أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إذا كان ذلك ممكنًا. ناقش المكان الذي سيقرب فيه المريض. احصل على وعاء سرير أو مرحاض أو مكان قريب الحمام جاهز للاستخدام.	وهذا يضمن خصوصية المريض.
7. اضبط السرير على ارتفاع عمل مريح، وعادةً ما يكون ارتفاع مرفق مقدم الرعاية. ضع المريض على الجانب الأيسر (وضع سيمز)، وفقًا لما تمليه راحة المريض وحالته.	يسهل وضع Sims' تدفق يتم نقل المحلول عن طريق الجاذبية إلى المستقيم والقولون، مما يؤدي إلى تحسين الاحتفاظ بالمحلول.
قم بطي الكتان العلوي للخلف بما يكفي السماح بالوصول إلى منطقة المستقيم للمريض. قم بتغطية المريض ببطانية الحمام، حسب الضرورة، للحفاظ على الخصوصية وتوفير الدفء. ضع وسادة مقاومة للماء تحت ورك المريض.	إن طي الكتان للخلف بهذه الطريقة يقلل من التعرض غير الضروري ويعزز راحة المريض ودفئه. الوسادة المقاومة للماء سوف تحمي السرير.
8. ارتدي القفازات.	القفازات تمنع ملامسة الدم و سوائل الجسم.
9. إزالة الغطاء المعبأ مسبقًا محلول الحقنة الشرجية. تطبيق سخية كمية مادة التشحيم للأنبوب.	التشحيم ضروري لتقليل صدمة عند الإدخال.



يساعد التنفس العميق على استرخاء الشرج، إكمالاً لعملية تصوير الجيد لفتحة الشرج العضلة العاصرة. 	10. ارفع الأرداف لكشف فتحة الشرج. اطلب من المريض أن يأخذ عدة أنفاس منع عميقة. قم بإدخال الأنبوب المستقيمي ببطء ولطف على مسافة 3 إلى 4 بوصات (7 إلى 10 سم) للشخص البالغ.
يساعد لف الحاوية على الإدارة جميع محتويات الحاوية.	11. اضغط على الحاوية بيديك. قم بلف الطرف على نفسه، باتجاه طرف المستقيم. قم بإعطاء كل المحلول الموجود في الحاوية. تقييم الدوخة والدوار والغثيان والتعرق والجلد الرطب أثناء الإدارة.
إذا تم تحرير الحاوية، فسوف يحدث فراغ شكل جاهز، يسمح ببعض الحقنة الشرجية الحل لإعادة الدخول إلى الحاوية.	12. قم بإزالة الحاوية مع الاحتفاظ بها أنها مضغوطة. احصل على منشفة ورقية لاستقبال الأنبوب كما هو منسحب.
	13. اطلب من المريض الاحتفاظ بمحلول الحقنة الشرجية لمدة 30 دقيقة على الأقل أو كما هو مبين.
	14. قم بإزالة القفازات الخاصة بك. يعود وضع المريض في وضع مريح. تأكد من جفاف البياضات الموجودة أسفل المريض وتأكد من جفاف المريض مغطى.
	15. رفع السكة الجانبية. خفض ارتفاع السرير وضبط رأس السرير ليكون مريحًا وضع. يعزز سلامة المرضى.
	16. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية الإضافية، إذا تم استخدامها. قم بإجراء نظافة اليدين.
17. عندما يكون لدى المريض رغبة قوية في تبيد المحلول، ضعه في وضعية الجلوس على وعاء السرير أو إلى المرحاض أو الحمام. ابق مع المريض أو اجعل جرس الاتصال متاحًا بسهولة.	الوضعية الجلوس هي الأكثر طبيعية وتساعد عملية التخليص بالمقابة إلى الهياكل هي الوصول إلى المرحاض.
18. ذكّر المريض بعدم التنظيف قم بفحص نتائج الحقنة الشرجية قبل فحصها، إذا تم استخدامها لإخراج الأمعاء. سجل ك شخصية البراز، من مناسب، ورد فعل المريض عليه الحقنة الشرجية.	النتائج تحتاج إلى ملاحظة و مسجل.

19. اترك المريض نظيفًا ومريحًا. العناية بالمعدات بشكل صحيح	يمكن أن تكون البكتيريا التي تنمو في الأمعاء تنتشر إلى الآخرين إذا لم تكن المعدات متوفرة تم تنظيفها بشكل صحيح.
20. قم بإجراء نظافة اليدين.	نظافة اليدين تمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة.
21. قم بتوثيق كمية ونوع محلول الحقنة الشرجية المستخدم؛ وطول الوقت الذي يحتفظ به المريض؛ وكمية البراز وقوامه ولونه، حسب الاقتضاء؛ وأي خلل.	

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف فغر القولون.
- تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.
- تطبيق إجراء الحقنة الشرجية.

التعريف: فغر القولون هو إنشاء فغرة من جزء من القولون (كبير الأمعاء)، حيث يتم إدخال الأمعاء عبر جدار البطن وربطها بالجلد، وتحويل البراز المعوي الطبيعي عبر الفغرة بدلاً من فتحة الشرج.

أنظمة الأكياس (أجهزة فغر القولون):

الأفراد الذين يعانون من فغر القولون ليس لديهم سيطرة أو إحساس بتردد أو إخراج الفغرة. يجب على المرضى الذين يعانون من فغر القولون ارتداء نظام كيس لجمع النفايات السائلة من الفغرة وحماية الجلد من التهيج. نظام الأكياس يجب أن تكون مغلقة بالكامل لمنع تسرب النفايات السائلة ولحماية الجلد المحيط بالفغرة. يمكن أن تكون أنظمة الأكياس التي تستخدم لمرة واحدة إما نظامًا مرئيًا من قطعة واحدة أو قطعتين يتكون من كيس بلاستيكي وشفة (حاجز جلدي) توضع على جلد المريض. قد تكون الحافة مسطحة أو محدبة. ➤ إجراءات العناية بفغر القولون

اعتبارات السلامة:

- يجب تغيير نظام الكيس كل 4 إلى 7 أيام، اعتمادًا على المريض ونوع الكيس.

- استشر دائمًا أخصائي العناية بالجروح أو ما يعادله في حالة حدوث انهيار في الجلد، أو في حالة تسرب الكيس، أو في حالة وجود مخاوف أخرى تتعلق بنظام الكيس.
- يجب على المرضى المشاركة في رعاية عملية فغر القولون الخاصة بهم، ويجب على مقدمي الرعاية الصحية تعزيز مشاركة المريض وأسرته.
- تشجيع المريض على إفراغ الكيس عندما يكون ربعه إلى نصفه ممتلئًا بالبراز، ويعتمد اختيار منتجات فغر القولون على احتياجات المريض وتفضيلاته.
- متابعة جميع التقييمات بعد العملية الجراحية للفغرات الجديدة وفقًا لسياسة الوكالة.
- قد تحتاج الأدوية والنظام الغذائي إلى تعديل من أجل إجراء عمليات فغر القولون الجديدة.
- يمكن استخدام حزام فغر القولون للمساعدة في تثبيت كيس فغر القولون في مكانه.
- العوامل التي تؤثر على نظام الأكياس تشمل التعرق والحرارة العالية والبشرة الرطبة أو الدهنية وممارسة الرياضة البدنية.
- عالج دائمًا تهيجات الجلد البسيطة على الفور. من الصعب إغلاق الجلد المؤلم أو الرطب أو الأحمر بشفة للحصول على ملائمة مناسبة مانعة للتسرب.

➤ **إجراء**

عقلاني هذا يمنع ال انتشار من الكائنات الحية الدقيقة.	خطوات 1. قم بإجراء نظافة اليدين.
تشمل الإمدادات الحافة، وكيس الفغرة والمشبك، والمقص، ودليل قياس الفغرة، ووسادة مقاومة للماء، وقلم رصاص، ومزيل لاصق للجلد، ومسحوق، وقماش مبلل، وقفازات غير معقمة، وأقمشة إضافية.	2. جمع الإمدادات. 
3. تحديد هوية المريض ومراجعته وتشجيع المرضى على المشاركة يساعد	إجراء. شجع المريض على التكيف مع وجود فغر القولون المشاركة قدر الإمكان أو مراقبة/مساعدة المريض أثناء إكماله إجراء.
تمنع الوسادة انسكاب النفايات السائلة على المريض وملاءات السرير.	4. خلق الخصوصية. ضع وسادة مقاومة للماء تحت الحقيبة.
إزالة لطيفة تساعد على منع تمزقات الجلد. آن يمكن استخدام مزيل المواد اللاصقة لتقليل تقشير الجلد والشعر.	5. استخدم القفازات. إزالة كيس الفغرة، وقياس وإفراغ المحتويات. ضع نظام الأكياس القديم فيه كيس قمامة 
6. قم بإزالة الحافة عن طريق سحبها برفق نحو الفغرة. ادمع بشرتك بيدك الأخرى. يمكن استخدام مزيل لاصق	6. قم بإزالة الحافة عن طريق سحبها برفق نحو الفغرة. ادمع بشرتك بيدك الأخرى. يمكن استخدام مزيل لاصق 

7. تنظيف الفغرة بلطف عن طريق المسح بالتنظيف القوي يمكن أن يسبب النزيف. إذا

قم بإزالة معجون لاصق الفغرة من الجلد،
واستخدم قطعة قماش جافة أولاً.

ماء دافئ. لا تستخدم الصابون.



يجب أن يكون لون الفغرة ورديًا إلى أحمر،
ومرتفعًا فوق مستوى الجلد، ورطبًا.

8. تقييم الفغرة والجلد التمعجي.



9. قم بقياس قطر الفغرة باستخدام يجب أن تكون الفتحة أكبر بمقدار 2 مم من

احتفظ بدليل القياس مع المريض

دليل القياس (قالب التتبع) وحجم الفغرة.

قطع فتحة الفغرة.

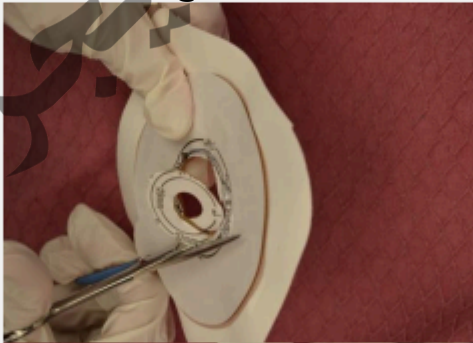
قطر أثر مستلزمات دليل القياس للاستخدام المستقبلي

على الحافة، وقطعها من الخارج

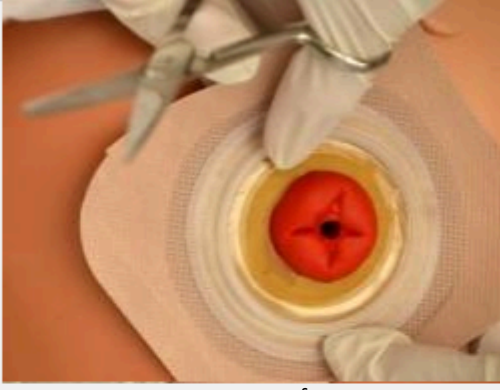
علامة القلم



قالب التتبع



بمجرد تتبع الحجم على الجزء الخلفي من الحافة، قم بقطعه
الحجم المناسب للفغرة



تقييم الحافة للتأكد من ملاءمتها للفغرة

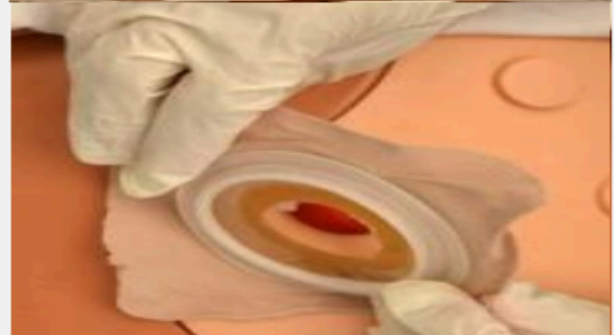
الجلد الرطب سوف يمنع الحافة من ملتصقة بالجلد.

9. حضري بشرتك وضعي عليها الإكسسوار المنتجات حسب الحاجة أو وفقًا لسياسة الوكالة.



10. قم بإزالة الجزء الداخلي من الحافة ويمكن أن يساعد دفع اليد في وضع الحافة فوق الفغرة. اترك الجهاز ملتصقًا بالجلد وامنعه

شريط الحدود على. تطبيق الضغط. امسك التسرب. في مكانه لمدة دقيقة واحدة لتدفئة شفة لتندمج مع جسم المريض. ثم قم بإزالة دعم الحدود الخارجية واضغط بلطف لإنشاء الختم.



		
هذه الخطوة تمنع تلوث النفايات السائلة المريض أو السرير.	11. قم بوضع كيس الفغرة. إرفاق قم بتثبيتته في أسفل الحقبة.	 
	13. امسك راحة اليد فوق كيس الفغرة، حيث يتم تنشيط الحافة بالحرارة. لمدة دقيقتين للمساعدة في الجهاز ملتصقة بالجلد.	
يساعد إزالة القمامة على تقليل الرائحة.	14. تنظيف الإمدادات ووضع المريض وضع مريح. إزالة القمامة من غرفة المريض.	
وهذا يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة.	15. قم بإجراء نظافة اليدين.	
توثيق مظهر الفغرة والجلد المحيط بالفغرة والمنتجات المستخدمة وقدرة المريض على تحمل الإجراء و المساعدة في الإجراء.	16. إجراءات التوثيق.	

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

• تحديد المعدات اللازمة أثناء الإجراء.

• تطبيق الرعاية الروتينية بالقسطرة.

نظرة عامة على المهارة

- يتم استخدام القسطرة الدائمة لتصريف البول من المثانة ولكنها قد توفر طريقًا لدخول العدوى إلى الجسم. لذلك، يجب الحرص على التأكد من أن المنطقة المحيطة نظيفة لتقليل تلوث القسطرة بالنباتات البكتيرية.

- **الهدف:** تظل بشرة المريض نظيفة وجافة وسليمة ولا يوجد دليل على تهيجها أو انهيارها؛ ويعرب المريض عن فهمه للغرض من القسطرة والعناية بها، حسب الاقتضاء

> معدات

- مجموعة معبأة مسبقًا
- محلول مطهر
- مسحات معقمة
- قفازات نظيفة
- وعاء معقم
- اغسل القماش والصابون والماء
- قماش الكلورهيكسيدين 2% (اختياري)

> إجراء

خطوات	عقلاني
1. اغسل يديك.	يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة.
2. تحقق من بروتوكول الوكالة أو خطة الرعاية.	يضمن الإجراء المناسب.
3. تحديد العميل وشرح الإجراء. يقوم بإعداد العميل.	
4. توفير الخصوصية.	يحمي كرامة العميل.
قسطرة. أنش في وضعية الاستلقاء الظهرى. ب- ذكر في وضعية الاستلقاء.	5. وضع المريض باستخدام وسادة مقاومة للماء يسمح بنصور المجال. إذا لم تتمكن من رؤية منطقة العجان تحت الأرداف وتغطيتها بالحمام باستخدام بطانية العميل، مع كشف المنطقة التناسلية فقط والاستلقاء على الظهر، فحاول وضع العميل في وضع الاستلقاء على الجانب وضع.
6. ارتدي قفازات نظيفة.	يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة.
ماء. الخيار: استخدم الكلورهيكسيدين 2% قماش	7. تنظيف منطقة العجان بالصابون والصابون له خصائص مصادة للبكتيريا كافية نظف المنطقة ولن يسبب تهيجًا عادةً الجلد أو الأغشية المخاطية.

يوفر تصوّرًا كاملاً للصماخ الإحليلي. كامل انفصال من الشفرين يمنع تلوث القناة الصفراوية أثناء التنظيف. ويؤدي سحب القلفة إلى توفير رؤية كاملة للمجرى البولي.	8. رعاية القسطرة: أ. الأنثى: استخدم اليد غير المهيمنة لـ افصل الشفرين بلطف لكشف مجرى البول والقسطرة بالكامل. حافظ على وضعية اليد طوال الإجراء. ب. ذكر: استخدم يدًا غير مهيمنة لسحب القلفة إذا لم تكن مختونة، أمسك القضيب عند العمود أسفل الحشفة مباشرةً. الحفاظ على وضع اليد طوال الإجراء 
9. تنظيف القسطرة من فتحة الشرج إلى الخارج لا يؤدي إلى نقلها من المنطقة الأكثر نظافة إلى الخارج	نهاية القسطرة، مع الحرص على عدم سحب مجرى البول أو المثانة بشكل مؤلم. على القسطرة. 
يمنع العدوى.	10. تأكد من تكرار العناية بالقسطرة في أي وقت تصبح فيه متسخة بالبراز أو أي تصريف آخر.
11. ضع كرات الكتان أو القطن في مكانها الصحيح مما يقلل من انتقال العدوى إلى الآخرين عملاء.	وعاء للغسيل أو التخلص منه.
يقلل من انتقال الكائنات الحية الدقيقة.	12. اغسل يديك.

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	المحاكمة 3	تعليق
1. اغسل يديك.					
2. تحقق من بروتوكول الوكالة أو خطة الرعاية.					
3. تحديد العميل وشرح الإجراء.					
4. توفير الخصوصية.					
5. ضع المريض مع وسادة مقاومة للماء تحته الأرداف والغطاء ببطنية الحمام، كشف المنطقة التناسلية والقسطرة فقط. أنشئ في وضعية الاستلقاء الظهرى. ب- ذكر في وضعية الاستلقاء.					
6. ارتدي قفازات نظيفة.					
7. تنظيف منطقة العجان بالماء والصابون. الخيار: استخدم قماش الكلورهيكسيدين 2%.					
8. رعاية القسطرة: أ. أنشئ: استخدم اليد غير المهيمنة بلطف لفصل الشفريين لكشفهما بالكامل مجري البول والقسطرة. حافظ على وضعية اليد طوال الإجراء. ب. ذكر: استخدم اليد غير المهيمنة لسحب القلفة إذا لم يتم ختانها و امسك القضيب عند العمود الموجود أسفل الحشفة مباشرة. الصيانة وضع اليد طوال الإجراء					
9. تنظيف القسطرة من فتحة الشرج إلى نهايتها من القسطرة، مع الحرص على عدم سحبها قسطرة.					
10. تأكد من تكرار العناية بالقسطرة في أي وقت تصبح فيه متسخة بالبراز أو أي تصريف آخر.					
11. ضع كرات الكتان أو القطن في المكان المناسب وعاء للغسيل أو التخلص منه.					
12. اغسل يديك.					

مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS)

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS).
- حدد هدف الحصول على مقياس غلاسكو للغيوبة.
- اشرح نظام تسجيل مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS).
- إظهار تقييم مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS).

> تعريف

- مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS) هو مقياس تقييم عصبي يقيم ثلاث فئات رئيسية من السلوك التي تعكس بشكل وثيق النشاط في المراكز العليا من الدماغ: **فتح العين والاستجابة اللفظية والاستجابة الحركية**. في كل فئة، يتم إعطاء كل مستوى من مستويات الاستجابة قيمة عددية.

> الهدف من الحصول على مقياس غلاسكو للغيوبة

- يتم استخدامه بشكل شائع في سياق صدمات الرأس، ولكنه مفيد أيضًا في مجموعة واسعة من المواقف الأخرى غير المرتبطة بالصدمات.
- يمكن للتقييم المنتظم لـ GCS للمريض تحديد العلامات المبكرة لتدهور الخلايا الدبقية العصبية.
- يتم استخدام GCS بالتزامن مع التقييمات العصبية الأخرى، بما في ذلك رد فعل حدقة العين وقياس العلامات الحيوية، لتقييم الحالة العصبية للمريض.

> محتوى مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS) ونظام التسجيل.

- يعد GCS تقييمًا أكثر دقة للحالة العقلية بمرور الوقت. بعض القيود يتضمن استخدام GCS عدم القدرة على تقييم النتيجة اللفظية بعد تنبيب المريض.
- هناك ثلاثة جوانب للسلوك يتم قياسها بشكل مستقل كجزء من تقييم GCS للمريض

✓ 4 نقاط

✓ فتح العين

✓ 5 نقاط

الرد اللفظي.

6 نقاط

الاستجابة الحركية

- النتيجة الإجمالية المصنفة على النحو التالي: المرضى الذين يفتحون أعينهم تلقائيًا ويطيعون الأوامر (مريض مستيقظ تمامًا ومتنبه وموجه) يسجلون إجماليًا (15) نقطة ، أفضل ما يمكن النتيجة، في حين أن المرضى المترهلين، الذين لا يفتحون أعينهم أو يتكلمون، يسجلون

الحد الأدنى (3) نقاط.

عنصر	استجابة النتيجة	استجابة
فتح العين	4	يفتح عينيه تلقائيًا عندما يقوم شخص ما الاقتراب
	3	يفتح العينين استجابة للكلام (نغمة طبيعية أو الصراخ)
	2	يفتح العينين فقط للمثيرات المؤلمة (يطبق الضغط بالقلم على الجانب الخارجي الجانبي الإصبع الثاني أو الثالث، لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ، ثم يطلق)
	1	لا يوجد استجابة للمثيرات المؤلمة
أفضل رد لفظي	5	يتحدث؛ موجهًا نحو الزمان والمكان والشخص
	4	يتحدث؛ مشوشًا بشأن الزمان أو المكان أو شخص؛ أي واحد أو كل المؤشرات
	3	يتحدث فقط بالكلمات أو العبارات التي تجعل لا معنى له في سياق الأسئلة
	2	يستجيب بأصوات غير مفهومة؛ لا توجد كلمات مفهومة و/أو أنين، التأوه أو البكاء استجابة لمثيرات مؤلمة
أفضل استجابة حركية	1	لا يوجد رد
	6	يستجيب بدقة للتعليمات؛ يطيع أمرًا بسيطًا، مثل "ارفع يدك اليسرى خارج السرير"
	5	يحدد موقعه (يحرك اليد إلى نقطة التحفيز) للمثيرات المؤلمة ومحاولات إزالة المصدر
	4	فعل منعكس للانشاء، ولكن غير قادر على تحديد مصدر الألم؛ حركة بلا هدف في الاستجابة للألم
	3	يثني المرفقين والمعصمين أثناء التمدد إلى الأسفل الساقين للألم؛ تقشير المواقف
	2	يمتد الأطراف العلوية والسفلية إلى الألم؛ تدهور الوضع
	1	لا توجد استجابة حركية للألم في أي طرف

عنصر	بالغ	1-5 سنوات	0-1 سنة
فتح العين			
4	بشكل عفوي	بشكل عفوي	بشكل عفوي
3	إلى الأمر	إلى الأمر	إلى الأمر
2	لألم	لألم	لألم
1	لا يوجد رد	لا يوجد رد	لا يوجد رد
درجة المريض			
الرد اللفظي			
5	موجه	كلمات مناسبة، عبارات	هديل، ثثرة، بيتسم
4	مشوش	كلمات غير لائقة	صرخات

3	غير مناسب كلمات	يبكي، يصرخ	صرخات غير لائقة، صراخ
2	عدم الفهم	همهمات	همهمات
1	لا يوجد رد	لا يوجد رد	لا يوجد رد
درجة المريض			
الاستجابة الحركية			
6	يطيع الأوامر	تلقائي	تلقائي
5	يحدد مكان الألم	يحدد موضع الألم	يحدد موضع الألم
4	ينسحب ألم	من انسحاب الانثناء الانسحاب الانثناء	
3	انثناء غير طبيعي	انثناء غير طبيعي	انثناء غير طبيعي
2	امتداد	امتداد	امتداد
1	لا يوجد رد	لا يوجد رد	لا يوجد رد
درجة المريض			
إجمالي المريض			
نتيجة			

- تشير درجة GCS من (11 إلى 13) نقطة إلى **الخمول**، تشير النتيجة (8 إلى 10) نقاط إلى **الغباء**، تشير النتيجة الأقل من 7 إلى **غيوبة** وتشير النتيجة 3 إلى **غيوبة عميقة**

Levels of Consciousness

Term	Responsiveness
Alert	Normal. Responds with minimal stimuli.
Awake	Somewhat confused on awakening, but fully oriented.
Confused	Oriented to person, but not time/place. Decreased attention span.
Delirious	Disoriented to time, place, and person. May have visual and auditory hallucinations.
Lethargic	Drowsy but follows simple commands. Requires increased stimulation to respond.
Obtunded	Indifferent to external stimulation. Responds with a word or two.
Stuporous	Responds to vigorous and continuous external stimuli. Limited spontaneous movement.
Comatose	Reflexive posturing or no response to any stimulus.

- ترتبط درجة GCS البالغة 13-14 نقطة بـ **إصابة خفيفة في الرأس**، ترتبط النتيجة من 8 إلى 12 نقطة بـ **إصابة متوسطة في الرأس** وترتبط النتيجة الأقل من 8 بـ **إصابة خطيرة في الرأس**

> إظهار تقييم مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS).

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	المحاكمة 3	تعليق
1. تم تنفيذ تقنية غسل اليدين باستخدام مبدأ 5 لحظات من نظافة اليدين					
2. تم التحقق من هوية المريض بشكل صحيح باستخدام معرفين.					
3. حصلت على الموافقة وتكون قادرة على شرح المريض/الجلسة حول الإجراء.					
4. ضمان خصوصية المريض أثناء الإجراء.					
5. اشرح نتائج GCS باستخدام EVM (العين الانفتاح والاستجابة اللفظية والاستجابة الحركية) وتدايها على النتائج غير الطبيعية.					
6. استخدم أداة الاتصال إذا لزم الأمر (لأي حاجز لغوي)					
7. فتح العين :					
- لاحظ ما إذا كانت العيون تفتح تلقائيًا.					
- اتصل باسم المريض مرتين إذا لم يكن المريض كذلك فتح عينيه .					
- تطبيق محفز الألم المحيطي (الضغط على الجزء الجانبي من فراش الظهر)					
8. الرد اللفظي					
- التحقق من اتجاه المريض عن طريق السؤال (الوقت، المكان والشخص)					
9. الاستجابة الحركية:					
- فحص المريض لمعرفة ما إذا كان يطيع الأوامر والتعليمات: (على سبيل المثال، الضغط على يدك، إغلاق/عيون مفتوحة					
- إذا كان المريض لا يطيع الأمر، قم بتطبيق محفز الألم المركزي (الضغط على العضلة شبه المنحرفة)					
- لاحظ ما إذا كان المريض يتفاعل مع الألم: (أي: تحديد موقع الانسحاب، والانتشاء غير الطبيعي وامتداد)					
10. احصل على شعلة لتقييم المريض رد فعل حدقة العين.					
- التحقق من حجم حدقة العين قبل التفاعل مع الضوء والقدرة على التمييز بين تفاعلات حدقة العين: (أي، سريع، بطيء، أو ثابت)					
11. إجراء تقييم صحيح للأطراف الحركات والقدرة على التمييز:					
- قوة عادية؛ ضعف خفيف؛ شديد ضعف؛ لا حركة؛ وضعية غير طبيعية (امتداد/ مرونة)					
12. تم نطقها وتوثيقها بشكل صحيح -تلخيص وتفسير والإبلاغ عن الحالات غير الطبيعية نتائج GCS.					

مقتبس من كاتانجوي، إي. (2019). تحسين كفاءة مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS) للممرضات في وحدة واحدة للسكتة الدماغية الحادة - مشروع مبادرة التمريض. مجلة ممارسة التمريض، 3(1)، 109-15.

رعاية مريض يعاني من شد الهيكل العظمي

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف الجر الهيكلي.
- حدد هدف تطبيق الجر.
- قم بإحصاء أنواع الشد والجذب الجلدي.
- إظهار الرعاية للمريض في عملية شد الهيكل العظمي.

> تعريف الجر

- يعني تطبيق قوة شد على جزء من الجسم أو أحد الأطراف بينما تسحب قوة شد مضادة في الاتجاه المعاكس.

> تعريف الجر الهيكلي

- يوفر الجر الهيكلي السحب لجزء من الجسم عن طريق ربط الوزن مباشرة بالعظم، باستخدام المسامير أو البراغي أو الأسلاك أو الملقط (جر الجمجمة). يتم استخدامه لشل حركة جزء من الجسم لفترات طويلة. تستخدم طريقة الجر هذه لعلاج كسور عظم الفخذ والساق والعمود الفقري العنقي.

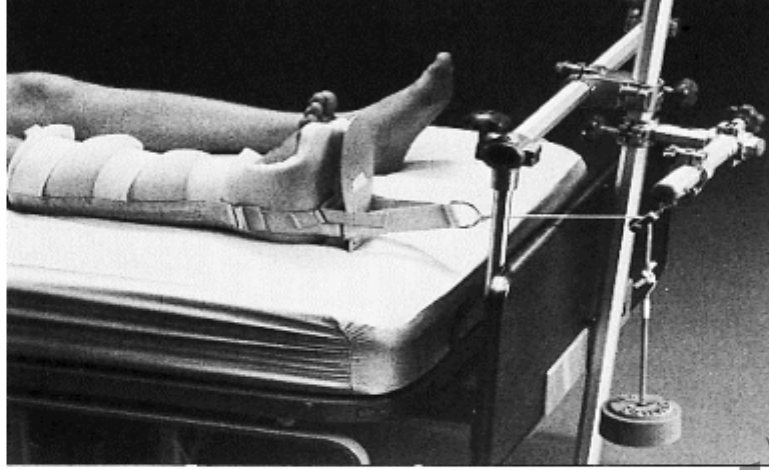
> الهدف من تطبيق الجر.

- لتأمين تثبيت أجزاء الكسر.
- لتقليل أو تقليل التشنجات العضلية.
- لتخفيف الألم.
- لإعادة تنظيم العظام.
- لمنع أو تصحيح التشوه و
- لزيادة المساحة بين الأسطح المتقابلة

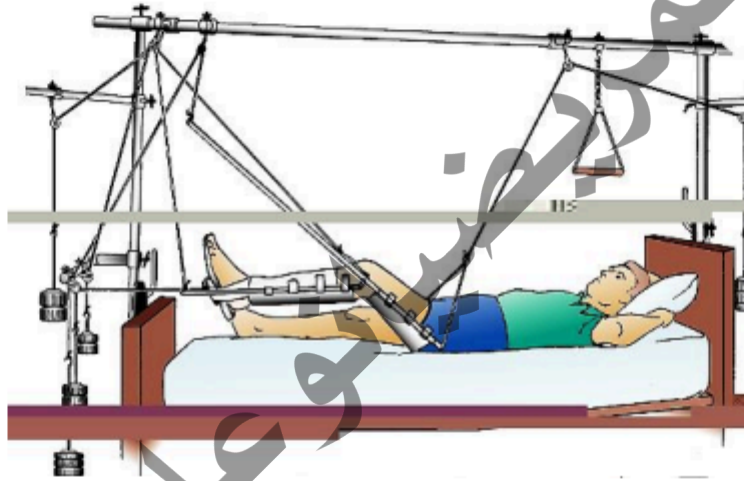
> أنواع الجر:

- الجر المستقيم أو الجاري.
- التعليق أو الجر المتوازن.
- الجر اليدوي.
- الجر الهيكلي
- شد الجلد.

- الجر المستقيم أو الجاري. يطبق قوة السحب في خط مستقيم مع وضع جزء الجسم في السرير.



- التعليق أو الجر المتوازن. يدعم الطرف المصاب بعيدًا عن السرير ويسمح ببعض حركة المريض دون تعطيل خط السحب



- شد الجلد. هو تطبيق قوة شد على الجلد والأنسجة الرخوة، والمواد المستخدمة بما في ذلك ضمادة التغليف والأشرطة والرافعات والأشرطة.



- **الجر الهيكل** يتم تطبيق الجر مباشرة على الهيكل العظمي باستخدام جهاز مثل المسامير والأسلاك والملقط في العظام بشكل مستمر لفترة طويلة.



- **الجر اليدوي** يعني شد الجسم باستخدام يد الشخص وقوته العضلية. يتم استخدامه في أغلب الأحيان لفترة وجيزة لإعادة محاذاة العظام المكسورة. يتم استخدامه لاستبدال العظم المخلوع إلى موضعه الأصلي داخل المفصل

➤ مبادئ الجر الفعال:

- يجب استخدام الجر المضاد لتحقيق الجر الفعال.
- يجب أن يكون الجر مستمرًا ليكون فعالاً في تقليل الكسور وتثبيتها.
- لا ينقطع الجر الهيكلي أبدًا.
- لا تتم إزالة الأوزان إلا إذا تم وصف الجر المتقطع.
- يجب إزالة أي عامل قد يقلل من السحب الفعال أو يغير خط السحب الناتج عنه:
- يجب أن يكون المريض في محاذاة جيدة لجسمه في منتصف السرير عند تطبيق الشد.
- يجب أن تكون الحبال مسدودة من قبل الأمم المتحدة.
- يجب تعليق الوزن بحرية وعدم وضعه على السرير أو الأرض.
- يجب ألا تلمس العقد الموجودة في الحبال أو صفيحة القدم البكرة أو قدم السرير

➤ مضاعفات الجر:

- انهيار الجلد،
- ضغط الأعصاب و
- ضعف الدورة الدموية.

➤ مضاعفات شد الجمجمة

- عدوى.
- يتحلل الجلد.
- تطبيق الجبيرة صعب.
- تشتيت الانتباه في موقع الكسر.
- تلف الأربطة.
- الضرر الجسدي.
- ندوب مكتنية.

➤ التدخل التمريضي:

1. الحفاظ على الجر الفعال.
2. الحفاظ على محاذاة الجسم.
3. منع انهيار الجلد.
4. الوقاية من ضعف الدورة الدموية.
5. مراقبة الحالة العصبية.
6. توفير العناية بموقع الدبوس.
7. تعزيز ممارسة الرياضة

➤ إجراء

عقلاني	خطوات
	1.مراجعة السجل الطبي والتمريض مراجعة السجل الطبي والخطة يتم استخدام الجر والرعاية الموصوفة. الإجراء الصحيح.
نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة. معدات الوقاية الشخصية هي الإرسال المطلوب احتياطات.	2.قم بإجراء نظافة اليدين. ارتدي معدات الوقاية الشخصية، كما هو محدد.
القلق وإعداد المريض لما لتوقع.	3.التعرف على المريض. شرح الإجراء: تحديد هوية المريض يؤكد صحة المريض، مع التركيز على أهمية المريض الصحيح والإجراء الصحيح. الحفاظ على التوازن والمحاذاة والمناقشة والشرح يساعد على التخفيف والموقف
إغلاق الباب أو الستائر يوفر الخصوصية.	4.أغلق الستائر حول السرير وأغلقها باب الغرفة إن أمكن
	5.إجراء تقييم الألم. إدارة تقييم الألم والإدارة الأدوية الموصوفة في وقت كاف تعمل المسكنات على تعزيز راحة المريض. للسماح بالتأثير الكامل للمسكن و/أو مرخيات العضلات
يقلل تطبيق الجر المناسب من خطر الإصابة من خلال تعزيز الدقة وظيفية الموازنة والجر	6.تأكد من تثبيت جهاز الجر بشكل آمن على السرير. تأكد من أن الأوزان تتدلى بحرية، ولا تلمس السرير أو الأرضية.
خط السحب ويمنع الإصابة.	7.التحقق من محاذاة جسم المريض، المحاذاة الصحيحة تحافظ على فعالية كما هو منصوص عليه.
توفر مواقع PIN إدخالاً محتملاً لـ الكائنات الحية الدقيقة. يسمح فحص الجلد الصرف الصحي، للكشف المبكر والسريع تدخل تطویر. ينبغي مضاعفات	8.قم بتقييم الموقع عند وحول المسامير بحثاً عن الاحمرار والوذمة والرائحة. تقييم خيمة الجلد، ارتفاع درجة حرارة الجسم لفترة طويلة أو قاحية، ارتفاع الدبوس درجة حرارة الموقع، والانحناء أو الانحناء الدبابيس.

التنظيف من المركز إلى الخارج يضمن الحركة من الأقل إلى الأكثر منطقة ملوثة.	9. توفير الرعاية في موقع الدبوس. أ. استخدام تقنية معقمة. ب. ارتدي القفازات المعقمة ج. قم بتنظيف موقع الدبوس، بدءًا من منطقة الإدخال والعمل للخارج، بعيدًا عن موقع الدبوس 
مرهم مضاد للميكروبات يساعد على تقليل لخطر العدوى. يساعد ارتداء الملابس في حماية الـ دبوس المواقع من التلوث واحتواء أي تصريف المياه.	10. اعتمادا على الطلب الطبي والمرافق السياسة، قم بتطبيق مواقع دبوس المرهم المضاد للميكروبات ثم ضع الضمادة.
تطبيق الجر بدون مريض إصابة	11. ضع السرير في أدنى وضع يضمن وضع السرير المناسب فعالية لا يزال يسمح للوزن بالتعليق بحرية.
إزالة معدات الوقاية الشخصية بشكل صحيح يقلل من المخاطر لعدوى انتقال و تلوث العناصر الأخرى. نظافة اليدين تمنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة.	12. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. إجراء نظافة اليدين

➤ قائمة التحقق من الإجراءات

خطوات الإجراء	علامة	المحاكمة 1	المحاكمة 2	المحاكمة 3	تعليق
1.مراجعة السجل الطبي والتمريض خطة الرعاية.					
2.قم بإجراء نظافة اليدين. ارتدي معدات الوقاية الشخصية، كما مُشار إليه.					
3.التعرف على المريض. اشرح الإجراء ل المريض.					
4.أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إن أمكن					
5.إجراء تقييم الألم. إداري مسكن للألم و/أو مرخي للعضلات					
6.تأكد من تثبيت جهاز الجر بشكل آمن على السرير. تأكد من أن الأوزان تتدلى بحرية، ولا تلمس السرير أو أرضية.					
7.التحقق من محاذاة جسم المريض، كما هو منصوص عليه.					
8.قم بتقييم الموقع عند وحول المسامير بحثًا عن الاحمرار والوذمة والرائحة. قم بتقييم خيمة الجلد، والتصريف المطول أو القيحي، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وارتفاع درجة حرارة موقع الدبوس، وانحناء أو ثني الجلد دبابيس.					
9.توفير الرعاية في موقع الدبوس. أ. استخدام تقنية معقمة. ب. ارتدي القفازات المعقمة ج. قم بتنظيف موقع الدبوس، بدءًا من الإدخال المنطقة والعمل في الخارج، بعيدًا عن موقع الدبوس					
10. ضع المرهم المضاد للميكروبات على الدبوس المواقع وتطبيق الضمادة على النحو الموصوف.					
11. ضع السرير في أدنى وضع لا يزال يسمح للوزن بالتعليق بحرية.					
12. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. أداء اليد صحة					

رعاية الممثلين

الأهداف:

سيكون الطلاب قادرين على:

- تعريف طاقم الممثلين.
- تحديد هدف تطبيق القالب.
- إظهار الاهتمام بإجراء الصب.

تعريف >

- الجبيرة عبارة عن جهاز تثبيت خارجي صلب يغلف جزءًا من الجسم. تُستخدم القوالب المصنوعة من الجبس أو المواد الاصطناعية، مثل الألياف الزجاجية، لتثبيت جزء من الجسم في وضع معين ولتطبيق ضغط موحد على الأنسجة الرخوة المغلفة.

> الهدف من تطبيق الجبس.

- شل حركة الهيكل المصاب.
- التقدم بطلب للحصول على كسر.
- تصحيح التشوه.
- توفير الدعم والاستقرار للمفاصل الضعيفة.

> الرعاية التمريضية بعد تطبيق الجبس

- التقييم المنتظم للمريض لمنع المضاعفات أو اكتشاف علامات المبكرة حتى يمكن البدء بالعلاج الفوري وتقييم الحالة العاطفية.
- تقييم الإحساس والدورة الدموية الكافية وخاصة إعادة تعبئة الشعيرات الدموية.
- الألم والضغط يجب على الممرضة عدم تجاهل أي من شكاوى الألم والضغط، فقد يكون ذلك بسبب ضغط الأوعية الدموية والأعصاب.
- قم بتوثيق والإبلاغ عن أي علامات للضغط تحت الجبيرة إذا لم يتم تخفيف الضغط قد تستنزف المنطقة النخرية وتتلطخ الجبيرة وتنبعث منها رائحة (رائحة كريهة).
- تذكر أن أعراض متلازمة الحيز تبدأ جميعها بـ "p" الألم والشلل وانعدام النبض.
- التقييم العصبي الوعائي: في جميع المرضى الذين خضعوا للجبس، يجب ملاحظة اللون والحركة ودرجة الحرارة وإحساس الأصابع أو أصابع القدم كل 30 دقيقة لعدة ساعات بعد تطبيق الجبس. (كل 3 ساعات في حالة وجود وذمة).
- يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى ظهور أعراض البرودة والألم والخدر في أصابع القدمين أو اليدين.
- النتائج الطبيعية: وذمة بسيطة، انزعاج بسيط، لون وردي، دافئ عند اللمس، استجابة سريعة لإعادة ملء الشعيرات الدموية (1:5 ثوانٍ)، إحساس طبيعي والقدرة على ممارسة الرياضة بالأصابع أو أصابع القدم

> إجراء

عقلاني	خطوات
	1. مراجعة السجل الطبي والتمريض مراجعة السجل الطبي وخطة العمل يتم استخدام الجر والإجراء الصحيح الموصوف. رعاية.
نظافة اليدين ومعدات الحماية الشخصية تمنع انتشار المرض من الكائنات الحية الدقيقة. معدات الوقاية الشخصية مطلوبة على أساس بشأن احتياطات الإرسال.	2. قم بإجراء نظافة اليدين. ارتدي معدات الوقاية الشخصية، كما هو محدد.
	3. التعرف على المريض. اشرح الإجراء تحديد هوية المريض للتحقق من صحة والموقف
إعداد المريض لما يمكن توقعه. إغلاق الباب أو الستائر يوفر الخصوصية.	4. أغلق الستائر حول السرير و أغلق باب الغرفة إن أمكن
يحافظ الحفاظ على الانحناءات والزوايا على محاذاة المفاصل المناسبة، ويساعد على منع المناطق المسطحة على الجبهة يجفف ويمنع مناطق الضغط.	5. إذا كان الجبهة على أحد الأطراف، فإن رفع الارتفاع يساعد على تقليل الوذمة و المنطقة المصابة على الوسائد المغطاة تعزز العود الوريدي. استخدام أ وسادات مقاومة للماء. الحفاظ على الوسادة العادية المقاومة للماء يمنع اتساع الكتان. انحناءات وزوايا الصب
	

يساعد التقييم على اكتشاف وظيفة الأوعية الدموية العصبية غير الطبيعية أو العدوى ويسمح بالتدخل الفوري. تقييم حالة الأوعية الدموية العصبية يحدد الدورة الدموية والأكسجين في الأنسجة. قد يزداد الضغط داخل الجبيرة مع الوذمة ويؤدي إلى متلازمة الحيز



كن منتهياً للشقوق أو الخدوش أو وجود تصريف من الجبس. قم بإجراء تقييمات الجلد والأوعية الدموية العصبية وفقاً لسياسة المنشأة، كل ساعة إلى ساعتين. فحص الألم، والوذمة، وعدم القدرة على تحريك أجزاء الجسم البعيدة عن الجبيرة، والشحوب، والنبضات، والأحاسيس غير الطبيعية. إذا كان الجبيرة على أحد الأطراف، قارنها بالطرف غير المصابوب



7. إذا كان النزيف أو التصريف الاختراقي، فإن وضع علامة على المنطقة يوفر خط أساس للملاحظة على الجبيرة، ووضع علامة على المنطقة عند مراقبة كمية النزيف أو الصب، وفقا لسياسة المنشأة. أشر إلى الصرف. التاريخ والوقت بجوار المنطقة.



العدوى تمنع الشفاء. تقييم يسمح بالكشف المبكر والسريع تدخل

8. تقييم علامات العدوى. مراقبة درجة حرارة المريض. قم بتقييم الرائحة الكريهة المنبعثة من الجبيرة، أو زيادة الألم، أو دفع شديد فوق منطقة من الجبس.

9. قم بتغيير وضع المريض كل ساعتين. إعادة التموضع يعزز التحفيف المتساوي

انزعاج المريض وانهيار الجلد.

السعال والتنفس بعمق.

إن وجود السرير على ارتفاع مناسب يضمن سلامة المريض.

10. ضع السرير في أدنى وضع، مع

القضبان الجانبية للأعلى.

11. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. يؤدي إزالة معدات الحماية الشخصية يدويًا بشكل صحيح إلى تقليل المخاطر

صحة.

ل عدوى انتقال و تلوث العناصر الأخرى. يد صحة يمنع ال انتشار من الكائنات الحية الدقيقة.

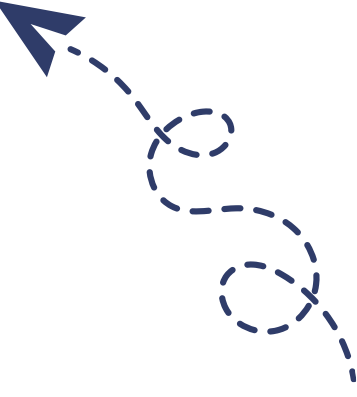
➤ قائمة التحقق من الإجراءات

تعليق	المحاكمة 3	المحاكمة 2	المحاكمة 1	علامة	خطوات الإجراءات
					1.مراجعة السجل الطبي والتمريض خطة الرعاية.
					2.قم بإجراء نظافة اليدين. ارتدي معدات الوقاية الشخصية، كما مُشار إليه.
					3.التعرف على المريض. اشرح الإجراء ل المريض.
					4.أغلق الستائر حول السرير وأغلق باب الغرفة إن أمكن
					5. ارفع المنطقة المصابة على الوسائد المغطاة مع وسادات مقاومة للماء. الحفاظ على الوضع الطبيعي انحناءات وزوايا الصب
					6.تقييم حالة الجبيرة.
					كن متيقظًا للشقوق أو الخدوش أو وجود الصرف من الجبس. قم بإجراء تقييمات الجلد والأوعية الدموية العصبية وفقًا لسياسة المنشأة، كل ساعة إلى ساعتين. تحقق من وجود ألم، وذمة، وعدم القدرة على تحريك أجزاء الجسم البعيدة عن الجبيرة، والشحوب، والنبضات، والأحاسيس غير الطبيعية. إذا كان الجبيرة على أحد الأطراف، قارنها بالجبيرة غير المصبوبة الطرف
					7.إذا حدث نزيف أو تصريف مفاجئ تم وضع علامة على المنطقة الموجودة على القالب، وتم وضع علامة على المنطقة الموجودة على القالب، وفقا لسياسة المنشأة. أشر إلى التاريخ والوقت بجوار المنطقة.
					8.تقييم علامات العدوى. مراقبة درجة حرارة المريض (درجة الحرارة، رائحة كريهة من الجبيرة، زيادة الألم، أو الدفء الشديد منطقة من الممثلين).
					9.قم بتغيير وضع المريض كل ساعتين. توفير العناية بالظهر والبشرة بشكل متكرر. تشجيع مجموعة من تمارين الحركة ل المفاصل غير المتضررة. تشجيع المريض على السعال والتنفس بعمق.
					10. ضع السرير في أدنى وضع، مع القضبان الجانبية للأعلى.
					11. قم بإزالة معدات الحماية الشخصية، إذا تم استخدامها. أداء اليد صحة.

مراجع

لين، ب. (2018). قوائم مراجعة المهارات لمهارات التمريض السريري لتايلور. ليبينكوت ويليامز وويلكينز. لين، ب. (2018). مهارات تايلور في التمريض السريري: نهج عملية التمريض. ليبينكوت ويليامز وويلكينز. مورتون، بي جي، وفونتين، دي كيه (2018). تمريض الرعاية الحرجة: نهج شامل (الطبعة الحادية عشرة). فيلادلفيا، بنسلفانيا: ولترز كلوير. بيرري، أ. جي، وبوتر، ب. أ. (2019). دليل موسيبي الجيني لمهارات وإجراءات التمريض - كتاب إلكتروني. إلسفير للعلوم الصحية. تايلور، سي، لين، بي، وبارتليت، جيه. (2022). أساسيات التمريض: فن وعلم الرعاية التي تركز على الشخص. ليبينكوت ويليامز وويلكينز. أوردن، إل دي، وستاسي، كيه إم، ولوف، إم إي (2020). الأولويات في تمريض الرعاية الحرجة (الطبعة الثامنة). سانت لويس، ميسوري: إلسفير

والث، وتمان، (2019): تمريض العناية المركزة: إطار للممارسة، الطبعة الرابعة، فيليب وودرو. ويلكنسون، جيه إم، وتريس، إل إس، وبارنيت، كيه إل، وسميث، إم إتش (2020). قوائم مراجعة الإجراءات لأساسيات التمريض. FA ديفيس. كاتانجوي، إي. (2019). تحسين كفاءة مقياس غلاسكو للغيوبة (GCS) للممرضات في وحدة واحدة للسكتة الدماغية الحادة - مشروع مبادرة التمريض. مجلة ممارسة التمريض، 3(1)، 15-109.



لمزيد من الملاحظات والكتب الطبية
يُرجى زيارة قناة ثانية تمريضيانو
على تطبيق التليجرام



للاضمام إلى القناة، يُرجى النقر على زر subscribe